# Systeem-Audit

Grensoverschrijdend bevoegdheidsvacuüm in de sociale zekerheid

## Document A — De narratieve audit

Auteur: Eric Messa

Versie bijgewerkt: 14 oktober 2026, 07:57

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave ..... 3
I. België ..... 6
Zorg & Fysieke Realiteit ..... 6
BAJART ORTHOPEDIE ..... 6
HUISARTSENPRAKTIJK TER VIERSCHAAR ..... 7
ONAFHANKELIJKE EXPERTS (BE) ..... 9
OOGARTSEN SINT-NIKLAAS ..... 10
ORTHOVANO ..... 12
UZ GENT ..... 13
VITAZ ..... 15
Financiën, Rechten & Sociale Zekerheid ..... 16
ALGEMENE CHRISTELIJKE VAKBOND (ACV) ..... 16
AGODI ..... 17
CHRISTELIJKE MUTUALITEIT ..... 18
FOD FINANCIËN ..... 20
FOD IBZ ..... 22
FOD SOCIALE ZEKERHEID (DG HAN) ..... 23
PARENTIA ..... 25
RVA ..... 26
SFPD ..... 28
VERTICO BUSINESS SOLUTIONS ..... 29
Escalatie & Controle ..... 30
CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN (CDZ) ..... 30
DE FEDERALE OMBUDSMAN ..... 31
DE KAMER (COMMISSIE SOCIALE ZAKEN) ..... 32
COMMISSIE VOOR VERZOEKSCHRIFTEN ..... 33
ARBEIDSAUDITORAAT GENT ..... 34
KONINKLIJK PALEIS VAN BELGIË ..... 35
ORDE DER ARTSEN ..... 36
POLITIEKE PARTIJEN & FRACTIES ..... 37
RIZIV ..... 38
UNIA ..... 40
II. Nederland ..... 41
Zorg & Verzekering ..... 41
CAK ..... 41
CZ ..... 42

ONAFHANKELIJKE EXPERTS (NL) ..... 43
PALLION HUISARTSENPRAKTIJK ..... 44
ZORGINSTITUUT NEDERLAND (ZIN) ..... 45
ZORGSAAM ..... 46
Financiën & Sociale Zekerheid ..... 47
BELASTINGDIENST ..... 47
GEMEENTE HULST & HULST VOOR ELKAAR ..... 49
ING NEDERLAND ..... 51
REIZEN DOOR ZEELAND ..... 53
RvIG ..... 54
STEDIN ..... 56
SVB & BBZ ..... 57
UWV ..... 58
VALYS ..... 60
VATTENFALL ..... 61
Escalatie & Controle ..... 62
DE NATIONALE OMBUDSMAN (NL) ..... 62
KONINKLIJK HUIS (NEDERLAND) ..... 63
NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN ..... 64
TWEEDE KAMER (COMMISSIE SZW) ..... 65
III. Overkoepelend, Bemiddeling & Maatschappelijke Resonantie ..... 66
ACADEMISCHE OBSERVATIELAAG ..... 66
BENELUX UNIE ..... 68
GRENSINFOPUNT (GIP) ..... 69
MEDIA & PUBLIEKE INTELLECTUELEN ..... 70
SOLVIT ..... 71
STRATEGISCHE BELANGENBEHARTIGING ..... 72
IV. Europa ..... 73
EUROPESE COMMISSIE ..... 73
EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EHRM) ..... 74
EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT (ELA) ..... 75
EUROPESE OMBUDSMAN ..... 76
EUROPEES PARLEMENT ..... 77
EUROPESE RAAD ..... 78
V. Internationaal ..... 79
VERENIGDE NATIES ..... 79

*Dit is Document A — De narratieve audit van het Systeem-Audit-project. Het beschrijft de organisaties die samen het netwerk vormen, als een reeks lopende verhalen.*

*Lees het als een reeks verhalen, niet als een database.*

# I. België

## Zorg & Fysieke Realiteit

### BAJART ORTHOPEDIE

*De Schoen die niet Paste*

Bajart Orthopedie is een orthopedisch schoenmaker met hoofdzetel te Bornem en een afdeling te Grembergen (Dendermonde). De organisatie werkt op voorschrift van artsen en specialisten en levert maatschoenen, semi-orthopedische schoenen en steunzolen binnen het Belgische terugbetalingsstelsel van het RIZIV. De facturatie loopt rechtstreeks met de adviserend arts van de mutualiteit; de patiënt betaalt enkel een remgeld.

Voor de aanvrager werd in 2025 een orthopedische schoen volledig op maat gemaakt, op voorschrift van dr. Hofman. De kostprijs van de schoen bedroeg meer dan € 2.500, waarvan het remgeld voor de patiënt ongeveer € 50 bedroeg. Vanaf de eerste testfase traden complicaties op: een bloedblaar onder de voorvoet, gevolgd door blijvende wrijvingspijn na elke aanpassing. De aanpassingen werden uitgevoerd op de afdeling te Grembergen, op ongeveer een uur rijden van de woonplaats van de aanvrager. Na elke aanpassing volgde hetzelfde patroon: het probleem bleef, de schoen bleef pijnlijk, en de aanvrager moest opnieuw de rit maken. Bij de definitieve afgifte op 12-09-2025 was de schoen nog steeds niet draagbaar. De klinische werkelijkheid — een naar boven afgebogen voet met ernstige diabetische neuropathie en eerdere amputaties — was niet in de schoen verwerkt.

Toen de aanvrager de schoen later meenam naar een gespecialiseerde orthopedisch schoentechnoloog binnen het Universitair Ziekenhuis Gent, stelde deze vast dat de schoen structureel te plat was gemaakt, zonder de vereiste opwaartse correctie en zonder voldoende binnenruimte voor de vervormde voet. De UZ Gent-specialist probeerde de schoen te herstellen, maar ook dit leverde geen bruikbaar resultaat op. De schoen bleef pijnlijk bij elke stap. Het eindresultaat is dat € 2.500 aan publieke middelen werd besteed aan een schoen die de patiënt niet kan aandoen, terwijl de patiënt zelf elke aanpassing met een uur reistijd en een fysieke terugslag heeft betaald.[*1*] [*2*]

*1* Factuur Remgeld 20/03/2026 – Order 25001331 – Bajart Orthopedie: geleverd op 12/09/2025 (Orthopedische schoenen links en rechts, afgietsels). Remgeld € 52,02.

*2* Factuur 20250193 d.d. 05-06-2025 – Verbandschoen PO500 maat 39/40 afgeleverd tijdens ziekenhuisopname, € 80,00, betaald op 26-05-2025.

# HUISARTSENPRAKTIJK TER VIERSCHAAR

*De Eerstelijnsbrug en Institutionele Ontkenning*

Anders dan de gesloten datasilo's van de regionale ziekenhuizen en de weigerachtige houding van de private sector, vormt de eerstelijnszorg de enige constante factor in het traject. Vanaf de pre-crisis nulmeting in het voorjaar van 2025 tot ver in het complexe post-operatieve stadium fungeert de huisartsenpraktijk als de centrale medische regisseur. De cruciale rol van deze actor ligt in de actieve doorbreking van de data-isolatie. Door de geactualiseerde medische samenvatting — inclusief de onomkeerbare amputaties, neuropathie en kritieke weefselafbraak — officieel te publiceren op het federale eHealth-knooppunt, worden deze feiten onweerlegbaar en real-time verankerd. Feitelijk is een beroep op ontbrekende medische informatie daarmee onhoudbaar geworden. De praktijk leert echter dat dit de uitkerende instantie niet weerhoudt om zich formeel alsnog te beroepen op het ontbreken van actuele huisartsverslagen, zoals de CM-ombudsman op 14 juli 2026 deed.

Wanneer de administratieve impasse over de landsgrenzen heen escaleert, vult de huisarts de leemte die de specialisten in de tweede lijn lieten vallen. De praktijk levert actief de systeemvertaling die de administratie eist. Zo worden de uitgebreide federale inlichtingenformulieren ter erkenning van de zware handicap ingevuld, worden er fiscale dieetbevestigingen opgemaakt en wordt er een overkoepelend getuigschrift van permanente arbeidsongeschiktheid afgeleverd. Hierin wordt de medische toestand niet benaderd als een tijdelijk te genezen defect, maar wordt de horizon van de invaliditeit realistisch vastgeklikt op de grens van de eenentwintigste eeuw.

De huisarts verricht daarnaast een unieke transnationale handeling door de grens van de eigen jurisdictie te overstijgen. De complexe en gestapelde medische problematiek (comorbiditeit) wordt methodisch geconverteerd naar de specifieke belastbaarheidsmatrix die aan de andere kant van de grens wordt gehanteerd *1*. Deze vertaalslag objectiveert een keiharde energetische limiet van maximaal vier uur actieve belasting per dag. Hiermee levert de Belgische eerstelijnszorg exact het gestructureerde instrumentarium waar de Nederlandse toezichthouder formeel om vraagt voor het vaststellen van het arbeidsvermogen.

De systeembreuk openbaart zich in dit stadium niet langer in het ontbreken van data, maar in de doelbewuste institutionele ontkenning ervan. Zowel het Belgische ziekenfonds als de Nederlandse uitkeringsinstantie weigeren het sluitende oordeel van de huisarts te accepteren, en kwalificeren deze medische en administratieve synthese als niet-bindend. Men erkent de ontvangst van de documenten, maar negeert de inhoud om de eigen afwijzingsprotocollen in stand te kunnen houden. Dit objectiveert een dwingende systeemparadox: toezichthoudende instanties eisen onafhankelijke medische data om rechten te kunnen toekennen, maar zodra die data sluitend en onweerlegbaar worden aangeleverd door de eerstelijnszorg, worden ze door diezelfde instanties administratief ongeldig verklaard.

*1* De Functionele Mogelijkhedenlijst (FML), het formele beoordelingsinstrument dat door de Nederlandse uitkeringsinstantie (UWV) wordt gebruikt om de fysieke en mentale belastbaarheid in kaart te brengen.

# ONAFHANKELIJKE EXPERTS (BE)

*Private Radiostilte en het Falen van Externe Validatie*

Wanneer zowel de ziekenhuissilo's als de toezichthoudende instanties weigeren om de versnipperde medische realiteit tot één afdwingbaar administratief geheel te smeden, ontstaat de noodzaak voor externe arbitrage. In het voorjaar van 2026 wordt een gerichte poging ondernomen om dit vacuüm te vullen via de private expertise-markt. Diverse onafhankelijke geneesheren-specialisten worden gecontacteerd met het verzoek om een overkoepelende, fysieke audit uit te voeren van de actuele belastbaarheid en zelfredzaamheid. Het doel is het creëren van een onweerlegbare medische nulmeting die als universeel referentiekader kan dienen voor zowel de Belgische als de Nederlandse beoordelingssystemen.

Deze private keuringsartsen opereren echter als volledig losgekoppelde eenheden. Zij zijn niet geïntegreerd in de nationale of grensoverschrijdende digitale gezondheidsnetwerken *1*, waardoor zij geen automatische toegang hebben tot de historische bewijslast. Wanneer zij via rechtstreekse kanalen worden geconfronteerd met het verzoek om een grensoverschrijdend, systemisch vastgelopen dossier te objectiveren, is de respons unaniem: een absolute radiostilte. Ondanks de aantoonbare aflevering van de digitale verzoeken, reageert geen enkele aangeschreven expert op de vraag naar medische arbitrage.

Deze collectieve weigering objectiveert een leemte in de beschermingsarchitectuur. Het systeem eist van de burger onafhankelijke en gestructureerde medische bewijzen om uitkerings- en fiscale rechten te kunnen ontsluiten, maar de private markt die deze bewijzen zou moeten leveren, trekt zich bij complexe transnationale frictie volledig terug. Hierdoor faalt de route van onafhankelijke macro-expertise fundamenteel. Het dwingt de patiënt om voor de noodzakelijke, overkoepelende attestering *2* alsnog terug te vallen op de reguliere eerstelijnszorg, die daarmee een verantwoordelijkheid op zich moet nemen die de gespecialiseerde private sector weigert te dragen.

*1* Digitale uitwisselingsplatformen zoals eHealth, CoZo of Vitalink, waardoor hun beoordelingen ook niet automatisch zouden doorstromen naar overheden of ziekenfondsen.

*2* De formele attestering van permanente arbeidsongeschiktheid, die uiteindelijk door de vaste huisarts moest worden opgemaakt ter overbrugging van de administratieve leegte.

## OOGARTSEN SINT-NIKLAAS

*Private Isolatie en de Registratie van Context*

Waar de academische en regionale ziekenhuizen nog opereren binnen een overkoepelende (zij het haperende) institutionele structuur, illustreert de specialistische privépraktijk de gevaren van een volledig geïsoleerde medische satelliet. Deze private oogheelkundige lijn wordt in de zomer van 2025 ingeschakeld voor de noodzakelijke nabehandeling van een vitrectomie en het toedienen van invasieve intraoculaire injecties om verdere weefselafbraak te vertragen. De praktijk functioneert echter buiten elke vorm van digitale netwerkintegratie. Er is geen enkele koppeling met de nationale eHealth-knooppunten of collaboratieve platformen. De patiënt wordt hierdoor gereduceerd tot een analoge datadrager, die zijn eigen ruwe klinische verslagen fysiek moet opvragen om deze in de netwerken van buitenlandse verzekeraars en federale overheden te injecteren.

De frictie in deze private schil wordt primair gedreven door een combinatie van financiële en logistieke uitsluiting. Omdat de patiënt door de Belgische ziekteverzekering administratief genegeerd wordt en de Nederlandse verzekeraar medisch grensvervoer weigert *1*, ontstaat er een onoverbrugbare drempel. De niet-geconventioneerde tarieven leiden tot een snelle financiële uitputting, resulterend in een verzamelfactuur van ruim veertienhonderd euro. Gecombineerd met het fysieke onvermogen om de praktijk te bereiken door het falende mobiliteitsnetwerk, wordt de patiënt in het najaar van 2025 gedwongen om de kritieke medische behandelingen te staken. Dit is geen klinische keuze, maar het directe resultaat van systeemfalen en financiële drooglegging.

De ware bestuurlijke paradox manifesteert zich echter in de registratie van deze gebeurtenissen. Wanneer de ruwe data maanden later wordt opgevraagd ter staving van het dossier, blijkt de privépraktijk de context van de behandelstop eenzijdig te hebben gewist. De gedwongen staking wegens financiële en logistieke overmacht wordt in het klinisch rapport foutief geclassificeerd als een vrijwillige weigering van de patiënt. Deze registratie werkt als een tijdbom in het verdere administratieve traject: buitenlandse verzekeraars en keuringsinstanties gebruiken deze geregistreerde 'weigering' later als een legitiem argument om eigen verantwoordelijkheden af te wijzen. De institutionele patstelling wordt hierdoor geformaliseerd als een patiëntkeuze.

Bovendien weigert de praktijk, in lijn met de regionale eerste lijn, elke vorm van administratieve medewerking. Wanneer er een functionele doorvertaling van de objectieve zichtverlies-data wordt geëist voor de federale keuringsinstanties *2*, stelt het secretariaat zich onbevoegd op en levert uitsluitend de onvolledige, ruwe klinische notities. Deze opstelling bevestigt een terugkerend patroon binnen de geprivatiseerde medische schil: men is bereid tot het uitvoeren van dure, invasieve procedures, maar weigert de administratieve verantwoording te nemen die noodzakelijk is om de maatschappelijke en financiële overleving van de patiënt te borgen.

*1* De Nederlandse zorgverzekeraar eiste voor de goedkeuring van ziekenvervoer een specifiek gezichtsveldonderzoek (perimetrie), een diagnostische parameter die binnen

het protocol van de Belgische privépraktijk niet werd afgenomen, wat leidde tot een onoplosbare grensoverschrijdende patstelling.

*2* Ten behoeve van de aanvraag voor een erkenning van ten minste 66% invaliditeit bij de bevoegde Belgische federale overheidsdienst.

# ORTHOVANO

*De Schoentechnoloog die de Fout Zag*

Orthovano is een gespecialiseerde orthopedisch schoentechnoloog, geaccrediteerd door het RIZIV en verbonden aan een academisch multidisciplinair netwerk rond orthopedisch schoeisel en steunzolen. De organisatie werkt vanuit vestigingen in Kortrijk en Gent en levert aan huisartsen, podologen en ziekenhuisspecialisten. Een belangrijk verschil met de klassieke orthopedische schoenmaker is dat de aanmeting, aanpassing en opvolging voor een deel op verplaatsing gebeurt: de technoloog komt tweemaal per maand op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent, zodat de patiënt niet telkens de fysieke rit naar de winkel moet maken. Dit is precies wat het traject voor de aanvrager vereenvoudigt: de schoenopvolging wordt gekoppeld aan de reeds geplande academische consultaties, wat de reislast halveert.

In het dossier van de aanvrager speelt Orthovano een sleutelrol als *auditor* van het eerdere traject. Toen de schoen werd meegebracht die eerder door Bajart Orthopedie op maat was gemaakt, stelde de schoentechnoloog vast dat de schoen structureel te plat was uitgevoerd, dat de vereiste opwaartse correctie voor de opwaarts afgebogen voet ontbrak, en dat er onvoldoende binnenruimte was voor de vervormde voorvoet met amputatiedefect. Dit oordeel verklaart waarom de eerdere aanpassingen keer op keer faalden: het was geen kwestie van bijsturen, maar van een ontwerpfout in de basisconstructie. Het feit dat een academisch verbonden schoentechnoloog tot deze conclusie komt, is een objectieve bevestiging dat het eerdere traject niet op medische gronden faalde, maar op constructieve gronden.

De overstap naar Orthovano betekent voor de aanvrager een fundamentele verschuiving: van een leverancier die de schoen na verkoop bleef aanpassen zonder de oorzaak te begrijpen, naar een technoloog die de schoen beoordeelt in samenhang met de klinische realiteit en de structurele fout durft te benoemen. De verdere zorg bestaat uit een nieuwe aanmeting, een constructie die rekening houdt met de opwaartse voetstand, en een opvolging die gecombineerd wordt met de academische endocrinologische en podologische controles in hetzelfde ziekenhuis.*1* *2*

*1* Contactgegevens zoals vermeld op de patiëntenkaart: Benoit Vanhoutte, orthopedisch schoentechnoloog, RIZIV 101850-74-000, benoit@orthovano.be, www.orthovano.be. Locatie Kortrijk: Universiteitslaan 4, T 056 21 86 69. Locatie Gent: Martelaarslaan 264, T 09 234 15 74.

*2* Eerdere constructie: Bajart Orthopedie, order 25001331, afgeleverd op 12-09-2025 (orthopedische schoenen links en rechts + afgietsels), remgeld € 52,02. De schoen bleek niet draagbaar; de structurele fout werd vastgesteld door de UZ Gent-schoentechnoloog.

# UZ GENT

*De Academische Overkoepeling en Protocollaire Frictie*

Als direct gevolg van de administratieve verlamming op het regionale niveau, verschuift het zwaartepunt van het dossier in het voorjaar van 2026 naar de academische tweede lijn. Dit universitair ziekenhuis wordt ingeschakeld om de gefragmenteerde en geïsoleerde medische realiteit te consolideren. Anders dan de perifere eilandcultuur hanteert deze instelling een multidisciplinaire aanpak, waarbij endocrinologie, gespecialiseerde wondzorg en oogheelkunde digitaal worden verweven. De opgebouwde data blijft hier niet opgesloten in een interne silo, maar stroomt via de gekoppelde eHealth-platformen *1* direct door naar het centrale nationale netwerk. De klinische feiten — zoals pathologische weefselschade en nierfalen — worden onweerlegbaar en real-time zichtbaar binnen het Belgische netwerk. Voor de Belgische toezichthouders wordt een beroep op ontbrekende data daarmee feitelijk onhoudbaar. In de praktijk blijft de handmatige tussenkomst echter bestaan: de adviserend arts van de CM beroept zich op een technische beperking (adviserend artsen zouden geen toegang hebben tot het eHealth/CoZo-netwerk), en de FOD Sociale Zekerheid blijft vasthouden aan papieren aanschrijvingen naast de digitale kanalen. Het beschikbaar maken van data betekent niet dat die data ook automatisch worden gebruikt. Voor de Nederlandse kant blijft die echter bestaan: de gegevens stromen niet automatisch door naar verzekeraar CZ of uitkeringsinstantie UWV. De patiënt blijft daar de handmatige schakel, omdat de grensoverschrijdende koppeling ontbreekt.

Toch botst ook deze hoogwaardige academische infrastructuur vrijwel onmiddellijk op de realiteit van de grens. De frictie ontstaat hier niet door onwil, maar door incompatibele nationale protocollen. Wanneer er acute, invasieve injecties in de oogbol noodzakelijk blijken ter bestrijding van verdere weefselafbraak, weigert de buitenlandse zorgverzekeraar in het woonland de logistieke ondersteuning (zittend ziekenvervoer) te vergoeden. Deze weigering is strikt gebaseerd op het ontbreken van een specifiek gezichtsveldonderzoek *2*, een administratief controle-instrument dat binnen de klinische protocollen van het Belgische academische ziekenhuis niet standaard wordt uitgevoerd voor deze aandoening. De grensarbeider raakt hierdoor logistiek bekneld in een vacuüm tussen twee systemen die elkaars medische standaarden en bewijslasten niet wederzijds erkennen.

Naast de grensoverschrijdende botsingen openbaren zich ook binnen de instelling zelf aanhoudende systeemfouten, veelal gedreven door strikte parameters in de software. Zo wordt een specifieke diabetische behandelconventie initieel geblokkeerd puur op basis van de buitenlandse domiciliëring van de patiënt, wat dwingt tot handmatige correcties om de toegang tot zorg te herstellen. Een fundamenteler breekpunt is de algoritmische categorisering van de aandoening. Een objectieve laboratoriummeting *3* bewijst definitief dat de alvleesklier niet bezwijkt onder een auto-immuunziekte, maar onder systematische overbelasting. In plaats van deze data te gebruiken voor medisch maatwerk, grijpt het administratieve systeem in: het dossier wordt onherroepelijk vastgeklikt in een strikte,

gedegradeerde classificatie *4*. Dit algoritme negeert de ernst van de reeds opgelopen amputaties en orgaanschade volledig, en blokkeert de vergoeding van geavanceerde sensortechnologie simpelweg omdat het toegekende label niet past bij de administratieve polisvoorwaarden.

Het cruciale en doorslaggevende verschil met de eerste lijn is echter de actieve bereidheid tot administratieve vertaling. Waar eerdere actoren weigerden de klinische feiten te converteren naar maatschappelijk bruikbare documenten, levert de academische structuur deze onmisbare sleutel wél. De specialisten produceren sluitende getuigschriften en vullen de complexe, vormstrenge documenten in *5* die de federale overheid eist. Hiermee objectiveren zij niet alleen de fysieke defecten, maar vertalen zij deze actief naar een blijvende verstoring van de biomechanica en een permanent verlies van zelfredzaamheid. Deze academische bekrachtiging doorbreekt de initiële patstelling, levert de forensische bewijslast die nodig is om de overheden in beweging te dwingen, en legt het fundament voor de escalatie naar de uitvoerende en controlerende instanties verderop in het netwerk.

*1* De collaboratieve zorgplatformen (zoals CoZo en Vitalink) die medische gegevens uitwisselen over Belgische zorgverleners heen.

*2* De perimetrie-eis, dwingend opgelegd door de Nederlandse zorgverzekeraar (CZ) als voorwaarde voor mobiliteitsvergoeding.

*3* Een negatieve anti-GAD bloedanalyse (<1.0 IU/mL).

*4* De formele administratieve classificatie 'Diabetes Type 2', waaraan inferieure terugbetalingsrechten voor continue glucosemeting (CGM) zijn gekoppeld, onafhankelijk van de werkelijke fysiologische schade.

*5* Waaronder 'Formulier 5' (het verplichte gezichtsonderzoek) bestemd voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ).

# VITAZ

*De Fysieke Basis en het Administratieve Verzuim*

Binnen het grensoverschrijdende netwerk functioneert deze regionale ziekenhuisinstelling als het primaire fysieke knooppunt. In het voorjaar van 2025 start hier de medische basis van het dossier met een acute spoedopname. Een zware verstoring van de stofwisseling leidt tot onomkeerbare weefselschade, wat meerdere chirurgische ingrepen noodzaakt. Er volgen amputaties aan de rechtervoet, huidtransplantaties, uitgebreide wondzorg en latere invasieve operaties om naderende blindheid te voorkomen. Deze intensieve zorgcyclus produceert een aanzienlijke hoeveelheid klinische en objectieve data over de fysieke toestand van de patiënt.

De werking van dit ziekenhuis legt een scherp contrast bloot tussen de medische en de administratieve realiteit. Hoewel alle verslagen, scans en bloedwaarden accuraat worden vastgelegd binnen het gesloten datasysteem van het ziekenhuis, blijven deze gegevens geïsoleerd. Er is geen sprake van een automatische doorstroom naar de systemen van de buitenwereld, zoals het Belgische ziekenfonds, de Nederlandse zorgverzekeraar of de keuringsinstanties voor arbeidsongeschiktheid. De facturatie voor de geleverde zorg verloopt soepel via de Belgische ziekteverzekering, wat de behandelingen in financiële zin legitimeert, maar de inhoudelijke medische kennis verlaat de muren van de instelling niet.

De structurele breuklijn in het systeem ontstaat wanneer de medische feiten administratief vertaald moeten worden. Uitvoeringsinstanties in zowel België als Nederland accepteren geen ruwe, ongestructureerde ziekenhuisdata; zij eisen specifieke syntheseverslagen en ingevulde formulieren van de behandelend specialist om maatschappelijke rechten — zoals een uitkering of grensvervoer — te kunnen toekennen. Wanneer hier in de lente van 2026 dwingend om wordt verzocht, weigert de gespecialiseerde tweede lijn echter haar medewerking. Via het secretariaat wordt meegedeeld dat men de situatie, ondanks de gedocumenteerde amputaties en aanhoudende fysieke uitval, administratief niet als een ernstige ziekte classificeert. De vereiste overkoepelende papieren worden niet ingevuld.

Hier manifesteert zich de fundamentele paradox van dit knooppunt. Het ziekenhuis presteert optimaal in het fysiek herstellen van de mens, maar laat na het instrument te leveren waarmee deze mens zich in de samenleving kan handhaven. Door de weigering om een administratieve vertaling te maken, valt de brug tussen de zorgverlener en de overheid definitief weg. Het gevolg is dat de patiënt zelf als handmatige data-koerier moet optreden en losse verslagen over de grens moet dragen in een vergeefse poging om vastgelopen overheidssystemen met elkaar te verbinden *1*. Deze eilandcultuur van de eerste lijn vormt de basis voor de kettingreactie van weigeringen die zich in een latere fase bij de verzekeraars en overheidsdiensten voltrekt.

*1* Conform de uitgangspunten van de Europese verordening inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) nr. 883/2004) wordt gestreefd naar een naadloze gegevensuitwisseling tussen lidstaten, waarbij de burger niet als administratief doorgeefluik tussen instanties mag worden belast.

# Financiën, Rechten & Sociale Zekerheid

## ALGEMENE CHRISTELIJKE VAKBOND (ACV)

*De Solidaire Grens en het Lidmaatschapsvacuüm*

Naast de reguliere overheidsdiensten kent het sociaal systeem ook particuliere beschermingsconstructies, waarvan de vakbond de grootste is. In de lente van 2026, wanneer de financiële uitputting door de blokkade bij het ziekenfonds (de CM) een kritiek punt bereikt, wordt een interne noodkreet uitgestuurd. Deze escalatie verloopt via de partner van de patiënt, die zelf niet alleen betalend lid is, maar bovendien functioneert als vakbondsafgevaardigde in het onderwijs *1*. Omdat het inkomen van het gezin en haar eigen fiscale rechten direct geraakt worden door de bestuurlijke impasse, roept zij de juridische bijstand van haar eigen organisatie in.

De reactie van de vakbondscentrale legt een beperking in de georganiseerde solidariteit bloot. De juridische dienst erkent de systeemfout volmondig. Men bevestigt zwart-op-wit de administratieve scheiding tussen invaliditeit (beheerd door de CM) en de erkenning van een handicap (voor de fiscus). Toch weigert de vakbond om de eigen juridische macht in te zetten tegen het weigerende ziekenfonds. De formele rechtvaardiging hiervoor is flinterdun: de patiënt zélf heeft geen lidnummer. Dat het betalende lid (de partner) zware financiële en administratieve nevenschade ondervindt door dit specifieke overheidsfalen, wordt genegeerd.

Hierdoor openbaart zich een nieuwe institutionele muur. Een collectieve organisatie die is opgericht om werknemers te beschermen tegen systeemonrecht, herkent de grensoverschrijdende systeemparadox en begrijpt de juridische context van de Europese wetgeving. Desondanks kiest de organisatie ervoor om niet in te grijpen en plooit zij terug op een strikte, individuele lidmaatschapsregel. De bestuurlijke blokkade wordt erkend, maar de solidaire bescherming stopt abrupt bij de administratieve grens van het eigen ledenbestand.

De scheiding tussen de juridische en de fiscale poot van dezelfde vakbond is tekenend. Waar de juridische dienst zich terugtrekt op de lidmaatschapsgrens, levert de fiscale dienst van het ACV Oost-Vlaanderen in september 2026 wél de praktische medewerking. Op 25 september 2026 controleert en dient de belastingservice de BNI-aangifte (aanslagjaar 2026) definitief in bij de FOD Financiën, inclusief de code invaliditeit voor de partner ten laste, het kind ten laste en twee attesten voor opvangkosten. Het berekende saldo bedraagt € 2.669,97 in het voordeel van het gezin.

*1* Aangesloten bij het Christelijk Onderwijzersverbond (COV), de onderwijscentrale van de overkoepelende vakbond ACV.

# AGODI

*De Procedurele Afschuiving en de Grens van de Loonadministratie*

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) is binnen de Vlaamse overheid belast met de uitvoering van het onderwijsbeleid voor het basis- en secundair onderwijs. Het agentschap beheert de financiële dienstverlening aan circa 4.000 scholen, de personeelsdossiers van meer dan 180.000 personeelsleden, en verzorgt de salarisbetaling van ruim 200.000 onderwijsmedewerkers *1*. In het dossier van de grensarbeider raakt AGODI betrokken via de loonadministratie van de partner, die als leerkracht in het Vlaamse onderwijs werkt. De frictie begint in maart 2026, wanneer de partner een retroactieve fiscale correctie aanvraagt op basis van het dubbelbelastingverdrag. AGODI weigert deze aanpassing omdat de fiscale fiches uit het verleden reeds zijn afgeleverd, en verklaart zich onbevoegd door te verwijzen naar de federale belastingdienst *2*.

Een tweede en scherper conflict ontstaat in augustus 2026, wanneer de partner verzoekt om de fiscale status van 'partner ten laste met handicap' te registreren, gestaafd met een federaal attest van 8 punten. AGODI reageert in eerste instantie door een medisch-fiscale beoordeling te maken: men stelt dat het attest uitsluitend geldig is voor een parkeerkaart en dat voor de bedrijfsvoorheffing een drempel van 9 punten geldt *3*. Wanneer de patiënt vervolgens een sluitend medisch getuigschrift indient waaruit blijkt dat de partner blijvend invalide is voor minstens 66 procent en het verdienvermogen verminderd is tot een derde, draait AGODI het beleid om. De instantie stelt plots dat zij geen documenten hoeft in te zien, dat de school een elektronisch signaal moet sturen, en dat de eindcontrole bij de belastingdienst ligt *4*.

De administratieve afronding volgt op 25 september 2026, wanneer het schoolsecretariaat via het personeelssysteem Informat de wijziging van de fiscale toestand registreert. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026 wordt vastgelegd dat de partner ten laste geen beroepsinkomsten heeft en als mindervalide staat geregistreerd. Wat eerder werd afgewezen op basis van een 9-punten-eis, is nu geregistreerd zodra de school het elektronische signaal heeft afgeleverd *5*. AGODI verschuift de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke beoordeling naar de federale fiscus en de school, en trekt zich terug uit het dossier.

*1* *1* AGODI, 'Taken van AGODI', Vlaanderen.be: uitvoering onderwijsbeleid, financiële dienstverlening aan scholen, beheer personeelsdossiers.

*2* *2* Entry 25-03-2026: weigering retroactieve fiscale correctie wegens reeds afgeleverde fiscale fiches; verwijzing naar FOD Financiën.

*3* *3* Entry 24-08-2026: AGODI stelt dat het attest van 8 punten enkel geldig is voor een parkeerkaart en dat 9 punten vereist zijn voor fiscale voordelen.

*4* *4* Entry 08-09-2026: na indiening van het wettelijk attest draait AGODI en stelt dat de school een elektronisch signaal moet sturen en de belastingen de eindcontrole hebben.

*5* *5* Entry 25-09-2026: registratie wijziging fiscale toestand mindervalide partner via het schoolsecretariaat.

# CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

*De Poortwachter en de Blokkade van Gegevens*

Na de foutloze administratieve overdracht door de private werkgever, belandt het dossier bij de poortwachter van de Belgische sociale zekerheid: het ziekenfonds. Hier transformeert de procedurele stroom direct in een aanhoudende institutionele blokkade. Vanaf het moment dat de acute fysieke uitval in het voorjaar van 2025 wordt gemeld, weigert deze instantie de inkomensvervangende uitkering toe te kennen. Initieel verschuilt men zich achter een interne registratiefout waarbij de tewerkstelling en het onafhankelijke lidmaatschap van maart 2025 worden genegeerd. Het essentiële verdragsformulier (S072) wordt pas eind juni 2025 naar Nederland doorgegeven, wat de technische oorzaak vormt voor onterechte geautomatiseerde weigeringen wegens 'geen hoedanigheid' in het voorjaar. Wanneer deze foutieve status onhoudbaar blijkt, werpt men een nieuwe, zwaardere barrière op: de weigering om het Europese recht toe te passen.

Binnen de Europese Unie is wettelijk vastgelegd dat gewerkte jaren over de landsgrenzen heen naadloos bij elkaar opgeteld moeten worden *1*. Het ziekenfonds negeert deze dwingende regelgeving echter volkomen en beoordeelt de aanvraag uitsluitend op basis van de eigen, nationale referteperiode. De decennialange opbouw van sociale rechten in twee verschillende landen wordt hiermee met één administratieve pennenstreek uitgewist.

De ware frictie in het systeem openbaart zich in de tegenstrijdigheid van het eigen handelen. Terwijl het ziekenfonds weigert het inkomensverlies te compenseren, keurt hun eigen adviserend arts wél duizenden euro's aan orthopedische hulpmiddelen en gespecialiseerde diabeteszorg goed. Men financiert de fysieke reparatie van de amputaties en erkent de medische arbeidsongeschiktheid formeel (medische erkenning I en II, juni 2025; bevestiging 18 september 2026), maar weigert de financiële consequentie: het uitkeringsrecht en het invaliditeitsattest dat daaruit zou moeten volgen. Deze paradox leidt tot een feitelijke patstelling wanneer de patiënt — om zijn fiscale voordelen te kunnen veiligstellen — uitsluitend om een medisch invaliditeitsattest verzoekt. Het ziekenfonds weigert dit af te leveren met als expliciet argument dat er geen financieel recht op een uitkering is. De objectieve medische waarheid wordt zo onlosmakelijk vastgeketend aan een intern budgettair besluit.

Om deze ontkenning in stand te houden, blokkeert de instantie de datastromen naar de buitenwereld. De registratie van de ziektestatus in de centrale, overkoepelende databank *2* wordt in de zomer van 2025 stopgezet, nadat de aanvrager na een reeks opeenvolgende weigeringen heeft besloten de handmatige indiening van getuigschriften te staken. Beide partijen versterken zo elkaars stilstand: de CM weigert te erkennen, en de aanvrager weigert de administratieve cyclus te blijven voeden die tot die erkenning zou moeten leiden. Hierdoor worden andere overheidsdiensten, zoals uitbetalers van kindergeld en de fiscus, volledig blind gemaakt voor de medische realiteit van het gezin. In het voorjaar van 2026 gaat de instantie nog een stap verder door een fictieve einddatum voor de ziekteperiode in de systemen in te voeren,

exact enkele dagen vóór de wettelijke grens van één jaar. Dit blokkeert de automatische wettelijke overgang naar de permanente invaliditeitsstatus.

Zelfs wanneer de patiënt via academische ziekenhuizen en het federale patiëntenportaal onweerlegbaar bewijs van blijvende orgaanschade aanlevert, weigert de interne ombudsdienst in te grijpen en valideert deze de geconstrueerde administratieve fictie. Het vangnet functioneert hier niet als bescherming, maar als de primaire bron van financiële en administratieve uitputting voor de burger.

In september 2026 bereikt de administratieve impasse haar definitieve vorm. Op 18 september stelt de dossierbeheerder dat de medische erkenning vaststaat, maar een uitkering wordt geweigerd wegens de nationale wachttijd, waarbij een lopend bezwaarschrift wordt genegeerd. Op 19 september volgt een formele ingebrekestelling van de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) wegens het niet verschaffen van systeemlogboeken en audit-trails. Eind september levert de DPO van toezichthouder RIZIV de finale objectivering van het systeemfalen: een onafhankelijke raadpleging van het nationale knooppunt bewijst zwart-op-wit dat er in de voorafgaande zes maanden geen enkel elektronisch bericht over het ziekte- of invaliditeitsdossier is uitgewisseld tussen de CM en de Nederlandse instanties (UWV of CZ) *3*. De CM verzuimt actief te communiceren via de dwingende Europese netwerken, waardoor de grensarbeider ongewild de enige overgebleven datalink vormt tussen twee natiestaten.

*1* Verordening (EG) 883/2004 en de dwingende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (onder meer het Vester-arrest C-134/18 en Casteels-arrest), die de naadloze samentelling van verzekeringstijdvakken binnen de Unie verplichten.

*2* De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), het centrale digitale netwerk dat alle Belgische overheidsdiensten van actuele statusgegevens van burgers voorziet.

*3* Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), het verplichte Europese netwerk voor digitale, geautomatiseerde uitwisseling van sociale zekerheidsgegevens tussen de nationale instanties van de lidstaten.

# FOD FINANCIËN

*De Fiscale Muur en de Cirkelredenering*

Terwijl het ziekenfonds de medische erkenning blokkeert, stuit het dossier bij de federale belastingdienst (FOD Financiën) op een vergelijkbare administratieve leegte. Deze instantie weigert echter niet expliciet om op te treden; zij verschuilt zich simpelweg achter een muur van bevoegdheden. Wanneer een burger door zware medische schade (zoals amputaties en ernstig visusverlies) zijn verdienvermogen verliest, heeft hij wettelijk recht op een financiële compensatie via de belastingen *1*. De fiscus weigert echter om de onweerlegbare medische attesten van de huisarts en academische specialisten zelf in behandeling te nemen of te beoordelen.

De belastingdienst stelt zich in dit dossier uitsluitend op als een procedurele rekenmachine. Om de belastingverlaging toe te passen, eisen zij een kant-en-klaar digitaal vinkje van een heel andere overheidsdienst: de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap). Omdat die instantie de medische erkenning maandenlang blokkeert, ontstaat er een klassiek en uitzichtloos 'van het kastje naar de muur'-scenario. De fiscus eist een document dat op dat moment niet geleverd kan worden, en weigert elke verantwoordelijkheid voor de impasse te nemen.

Wanneer de patiënt deze cirkelredenering probeert te doorbreken door de belastingdienst rechtstreeks een sluitend, overkoepelend invaliditeitsattest van de eigen huisarts te sturen, blijft de muur gesloten. De fiscus weigert niet alleen duidelijkheid te geven over de eigen beoordelingscriteria, maar levert zelfs het procedureel onuitvoerbare advies af om een Nederlandse arts de Belgische voorwaarden te laten evalueren. Een uitweg die wettelijk niet eens bestaat.

Zelfs wanneer de blokkade in augustus 2026 deels wordt doorbroken en er na een fysieke keuring een officiële federale erkenning van de handicap wordt afgeleverd, verwerpt de belastingdienst het behaalde medische besluit. De fiscus past de bestaande wettelijke norm toe: voor het specifieke fiscale voordeel is een score van minstens 9 punten vereist, terwijl de keuring 8 punten heeft toegekend. De zware medische realiteit wordt hierdoor ondergeschikt aan een scoreverschil van één punt — een verschil dat niet berust op een nieuw criterium, maar op de vaste drempelwaarde die al in de fiscale wetgeving staat.

Als ultieme tegenreactie op deze blinde, geautomatiseerde afwijzingen en het ontbreken van correcte internationale gegevensuitwisseling rondom het wereldinkomen, start de grensarbeider een formeel traject om de Europese datastromen op te eisen *2*. De fiscus, die blind vaart op falende digitale registers, wordt hierbij gedwongen om de eigen achterliggende techniek en de gebrekkige grensoverschrijdende communicatie met Nederland transparant te maken.

Toch blijkt de muur niet absoluut. Via een handmatige bypass — een rechtstreeks medisch attest van de huisarts bij de BNI-aangifte, buiten de KSZ en buiten DG HAN om — wordt de verhoogde belastingvrije som alsnog geactiveerd. De aangifte is op 25 september 2026 ingediend met een berekend

saldo van € 2.669,97 in het voordeel. Definitieve verwerking en aanslagbiljet van de FOD Financiën worden afgewacht. En in een onafhankelijke steekproef die een externe onderzoeker bij het Team Beheer en Dienstverlening van de Belasting Niet-Inwoners (PG15 Ledeberg) anoniem uitvoert, bevestigt de fiscus schriftelijk dat het spontaan toevoegen van medische verklaringen aan de aangifte een geldige route is om de fiscale handicapstatus naar Belgisch recht aan te tonen. De bypass is daarmee geen gok meer, maar een door de fiscus zelf gevalideerde weg.

*1* Artikelen 131 en 135 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), waarin de verhoogde belastingvrije som bij een zware handicap is vastgelegd.

*2* Verzoek tot inzage onder Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), specifiek gericht op de logbestanden van de Europese DAC-infrastructuur (Directive on Administrative Cooperation).

# FOD IBZ

*De Beheerder van het Rijksregister en de Grensoverschrijdende Datastroom*

De Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD IBZ) beheert het Rijksregister, de centrale databank waarin alle bevolkingsgegevens van natuurlijke personen in België zijn opgeslagen *1*. Daarnaast is de dienst verantwoordelijk voor de productie en verdeling van de elektronische identiteitskaart (eID), de vreemdelingenkaart en de Kids-ID *2*. In het netwerk van de grensarbeider fungeert FOD IBZ als de bron van het Rijksregisternummer, dat de basis vormt voor alle administratieve processen in België.

De frictie in dit dossier ontstaat bij de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling. Wanneer een burger zich vanuit België in Nederland vestigt, verwacht het systeem een naadloze synchronisatie tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse Basisregistratie Personen (BRP). In de praktijk blijkt deze interstatelijke datalink echter niet automatisch te functioneren. In september 2026 dient de patiënt een AVG-inzageverzoek in bij FOD IBZ om de elektronische logbestanden, systeemstempels en ruwe metagegevens van de uitschrijving naar Nederland in 2014 op te vragen *3*. Het verzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht in de grensoverschrijdende gegevensstromen.

De eerste poging om het verzoek per e-mail in te dienen, stuit op een serverblokkade (Access denied). Op 2 oktober 2026 wordt daarom een nieuwe aanvraag ingediend via de online website-interface van FOD Binnenlandse Zaken / Rijksregister *4*. De trage en gefragmenteerde afhandeling van het AVG-verzoek legt een bredere structurele breuk bloot: er bestaat geen geautomatiseerde, traceerbare synchronisatie tussen de Belgische en Nederlandse bevolkingsregisters bij een grensoverschrijdende verhuizing. De burger blijft afhankelijk van handmatige procedures om zijn eigen registratiegegevens over de grens te laten kloppen.

*1* FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken: beheer van het Rijksregister, de centrale databank met bevolkingsgegevens.

*2* FOD IBZ produceert en verdeelt de eID, vreemdelingenkaart en Kids-ID.

*3* Entry 02-09-2026: AVG-inzageverzoek bij FOD IBZ voor logbestanden en metagegevens van de uitschrijving naar Nederland in 2014.

*4* Entry 02-10-2026: nieuwe aanvraag via website-interface wegens e-mailbounce.

# FOD SOCIALE ZEKERHEID (DG HAN)

*De Territoriale Blokkade en Algoritmische Procedurefout*

Waar de belastingdienst zich verschool achter het ontbreken van een digitaal vinkje, toont het dossier bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap (DG HAN) precies aan waarom dat vinkje onmogelijk te verkrijgen was. Deze federale instantie beheert de formele erkenning van invaliditeit. Het proces loopt hier echter direct bij de voordeur vast op een fundamentele architectuurfout in de software. Wanneer de grensarbeider via het online overheidsportaal wil inloggen om zijn medische situatie te registreren, genereert het systeem onmiddellijk een harde foutcode (Error 5124). De oorzaak is louter territoriaal: het portaal accepteert uitsluitend Belgische adressen. Het systeem bezit letterlijk geen digitale categorie voor een burger die eenentwintig jaar lang in België werkte en sociale bijdragen betaalde, maar aan de andere kant van de landsgrens slaapt.

Deze digitale blokkade wordt door de instantie vervolgens vertaald naar een keihard beleidsstandpunt. Maandenlang weigert de dienst de aanvraag in behandeling te nemen. Zelfs wanneer er uitsluitend om een zuiver medische evaluatie voor fiscale doeleinden wordt verzocht — uitdrukkelijk losgekoppeld van enige vraag om een uitkering — stelt de overheid dat een Belgisch domicilie een absolute, onwrikbare voorwaarde is. Deze territoriale uitsluiting houdt pas op wanneer de patiënt via de Federale Ombudsman dwingende Europese rechtspraak op tafel legt *1*. Onder die juridische druk is de dienst uiteindelijk genoodzaakt toe te geven dat een landsgrens een medische diagnose niet mag uitsluiten, en wordt het dossier met zware terugwerkende kracht heropend.

Toch blijft de uitvoering na deze doorbraak diep geworteld in stroperige administratieve processen. Terwijl academische ziekenhuizen hun klinische bevindingen real-time via nationale, beveiligde datanetwerken *2* delen, negeert de FOD deze digitale snelwegen volkomen. De patiënt wordt bestookt met papieren brieven waarin op straffe van procedure-afsluiting wordt geëist dat hij handmatig ingevulde formulieren binnen dertig dagen aanlevert. Formulier 5 voor het gezichtsonderzoek kan weliswaar digitaal via het MyHandicap-portaal worden ingediend (op 30 juli 2026 ook zo gedaan), maar de FOD kiest voor de aanschrijving de papieren weg, wat tot tien dagen vertraging leidt en de wettelijke dertigdagentermijn onrechtmatig inkort. De burger blijft voor een groot deel van de communicatie een handmatige koerier voor data die de overheid via CoZo of eHealth zelf had kunnen ophalen.

Het ultieme breekpunt volgt na de fysieke keuring in Gent. De controlearts documenteert de onomkeerbare fysieke schade en levert eindelijk het langverwachte medische attest af, gewaardeerd op 8 punten voor verminderde zelfredzaamheid. Een kritische audit van dit verslag onthult echter ernstige structurele ontwerpfouten. Recente en objectieve meetgegevens uit de academische sector worden compleet genegeerd, en een geconstateerd valrisico en ernstig visusverlies worden onverklaarbaar tot nul punten weggestreept. Bovendien voert het algoritme ongevraagd een inkomensbeoordeling uit. Het resultaat van dit rapport is wiskundig: de toegekende 8 punten erkennen weliswaar de zware fysieke uitval, maar vallen exact één punt onder de magische drempel van 9 punten die de

belastingdienst (FOD Financiën) hanteert voor fiscale compensatie. De overheid levert hiermee een erkenning af die in de praktijk volstrekt onbruikbaar is, en dwingt de burger om het gehele, jarenlange bezwaartraject opnieuw op te starten.

*1* Verordening (EG) 883/2004 en de dwingende jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie, die garanderen dat Europese burgers niet mogen worden benadeeld op basis van hun woonplaats.

*2* Digitale infrastructuur zoals het eHealth-platform en het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), waar medische verslagen centraal beschikbaar zijn voor geautoriseerde instanties.

# PARENTIA

*De Geautomatiseerde Patstelling en de Gesloten Cirkel*

De kwetsbaarheid van een volledig geautomatiseerde overheid wordt nergens zo zichtbaar als in het dossier van Parentia, de private uitbetaler van de Vlaamse kinderbijslag en sociale toeslagen. Het algoritme van dit fonds is voor inkomensbepaling blindelings aangesloten op één centrale federale databank *1*. Wanneer de grensarbeider in het voorjaar van 2025 door medische amputaties zijn inkomen volledig verliest, registreert dit systeem die actuele financiële val niet. De automatische processen kijken namelijk twee jaar terug in de tijd. Gevolg: precies op het moment dat de medische en financiële crisis het hevigst is, wordt de sociale toeslag onverbiddelijk stopgezet op basis van inkomensgegevens uit 2023.

Wanneer de patiënt in het voorjaar van 2026 deze algoritmische fout probeert te corrigeren door handmatig medische attesten en bewijzen van inkomensverlies aan te leveren, ontstaat er een klassieke institutionele patstelling. Parentia erkent de aangeleverde medische bewijzen weliswaar, maar beroept zich op het ontbreken van de ziektestatus in de Kruispuntbank. De instantie constateert dat het ziekenfonds (de CM) deze status niet heeft doorgegeven en besluit passief te wachten tot de CM de data actualiseert. Het resultaat is dat een falende instantie (de CM) de uitbetaling van een andere instantie (Parentia) op afstand blokkeert, terwijl het gezin de financiële schade draagt.

Deze administratieve stilstand bereikt zijn hoogtepunt in september 2026. Nadat de patiënt een sluitend federaal attest van zware handicap en een doktersverklaring van permanente invaliditeit indient ter overbrugging van de ontbrekende CM-data, volgt een definitieve weigering. Die weigering is echter niet langer gebaseerd op de ontbrekende KSZ-registratie. Parentia toetst de inkomensvoorwaarde aan de hand van de ontvangen inkomstenattesten over de periode 1 november 2025 tot 31 maart 2026. Uit die attesten concludeert de instantie dat het gezinsinkomen geen zes opeenvolgende maanden onder de wettelijke drempel van € 3.957,10 per maand lag. Het systeem stempelt het huishouden daarmee administratief af als te welvarend voor een toeslag, terwijl het in de fysieke werkelijkheid door het falen van de overheid in een diepe liquiditeitscrisis verkeert.

Om deze bestuurlijke laksheid en het gebrek aan automatische grensoverschrijdende communicatie bloot te leggen, wordt uiteindelijk de privacywetgeving *2* als breekijzer ingezet. Via de compliance-afdeling van het fonds wordt een formele eis ingediend om de interne logbestanden en de gebrekkige Europese gegevensuitwisseling transparant te maken. De burger wordt zo gedwongen om technische controle-instrumenten in te zetten voor het afdwingen van fundamentele bestaansrechten die een geautomatiseerd systeem negeert.

*1* De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de digitale spil voor gegevensuitwisseling tussen Belgische sociale instellingen.

*2* Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dat burgers het recht geeft op volledige inzage in de verwerking en uitwisseling van hun data.

# RVA

*De Eenrichtingszender en het Europese Systeemfalen*

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) fungeert in dit dossier als de beheerder van het arbeidsverleden. Om sociale rechten in het buitenland te kunnen claimen, is een Europees bewijs van de opgebouwde werkingsjaren vereist *1*. Bij de aanvraag toont de instantie onmiddellijk een blinde vlek voor afwijkende loopbanen. Wanneer de partner, een vastbenoemde leerkracht, dit attest aanvraagt, blokkeert de RVA de procedure met de harde eis om een C4-formulier aan te leveren. Dit is een standaard ontslagdocument uit de privésector dat binnen het statuut van het onderwijs juridisch niet bestaat. De instantie perst een publieke loopbaan strikt in een private mal, wat de burger dwingt om zelf met regionale loonattesten de administratieve gaten tussen twee verschillende overheidsdiensten te dichten. Ook het eigen Belgische loopbaandossier blijkt incompleet, waarbij de patiënt vijf ontbrekende historische periodes handmatig moet laten aanvullen.

Het fundamentelere knelpunt betreft de absolute weigering om buitenlandse data te accepteren. Waar de RVA uiteindelijk wel de Belgische arbeidsjaren aanlevert, weigert de instantie categorisch om de eveneens aangeleverde Nederlandse loopbaangegevens in de centrale Belgische database op te nemen. De RVA stelt zich op het formele standpunt dat zij uitsluitend een zender van gegevens is en geen enkel mandaat heeft om inkomende Europese loopbaandata in de eigen systemen te integreren. De theorie van een naadloze Europese arbeidsmarkt fragmenteert hier in de praktijk. De patiënt transformeert ongewild tot een handmatige datakoerier die zijn buitenlandse werkdossiers fysiek moet overdragen aan een ander Belgisch ministerie (de FOD Sociale Zekerheid) om de gaten in zijn loopbaandossier te repareren.

Als ultieme reactie eist de burger via de privacywetgeving *2* de logbestanden van de haperende Europese datastromen op om de weigering tot geautomatiseerde samenwerking te objectiveren. Op 29 september 2026 levert de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO) van de RVA het sluitende bewijs: er heeft via het verplichte EESSI-netwerk *3* geen enkele elektronische gegevensuitwisseling met het Nederlandse UWV plaatsgevonden. De RVA legt de verantwoordelijkheid hiervoor feitelijk bij Nederland. De instantie stelt dat de elektronische uitwisseling steeds op initiatief van de ontvangende partij gebeurt en dat het UWV de informatie nooit heeft opgevraagd. Zonder een door het UWV geïnitieerde koppeling tussen het Burgerservicenummer en het Rijksregisternummer weigert de RVA op eigen initiatief elektronische gegevens te verzenden *4*. Deze patstelling objectiveert de architectuurfout perfect: het UWV wijst de uitkeringsaanvraag af in afwachting van een Belgische beslissing, terwijl de RVA niets verstuurt omdat het UWV niets opvraagt.

*1* Portable Document U1 (PD U1), het Europese formulier dat perioden van verzekering certificeert voor de vaststelling van werkloosheidsuitkeringen of samentelling van tijdvakken.

*2* Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), specifiek het inzagerecht conform Artikel 15 ter opvraging van de verwerkingslogboeken.

*3* Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), het verplichte Europese netwerk voor geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen lidstaten volgens Verordening (EG) 987/2009.

*4* Officiële brief Functionaris voor Gegevensbescherming RVA d.d. 29 september 2026, waarin het ontbreken van enig verzoek vanuit het UWV en de daaropvolgende weigering van de RVA tot spontane datatransmissie formeel wordt bevestigd.

## SFPD

*De Federale Pensioendienst en de Grensoverschrijdende Loopbaan*

De Federale Pensioendienst (SFPD) is de Belgische overheidsdienst die verantwoordelijk is voor de berekening en toekenning van wettelijke pensioenen voor werknemers en ambtenaren *1*. Tot de kerntaken behoren de toekenning van het rustpensioen, het overlevingspensioen en de overgangsuitkering van werknemers, evenals de betaling van pensioenen aan zelfstandigen en de inkomensgarantie voor ouderen *2*. Voor grensarbeiders is de SFPD een cruciale schakel, omdat zij de opgebouwde loopbaanjaren in België moet certificeren voor de berekening van pensioenrechten in het buitenland.

De frictie in dit dossier manifesteert zich bij de Europese gegevensuitwisseling. Om pensioenrechten in een andere lidstaat te kunnen vaststellen, is een uitwisseling van verzekeringstijdvakken via het EESSI-netwerk vereist. In september 2026 dient de patiënt een AVG-inzageverzoek in bij de SFPD om een afschrift te verkrijgen van alle verwerkte persoonsgegevens en de elektronische logbestanden, BUC's en SED's van de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling inzake pensioenen *3*. Het doel is om te controleren of de verplichte Europese gegevensuitwisseling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

De reactie van de SFPD bevestigt een structureel probleem. De Functionaris voor Gegevensbescherming deelt mee dat algemene persoonsgegevens via mypension.be te raadplegen zijn, maar dat EESSI-gegevens zich momenteel niet in de systemen van de SFPD bevinden. De burger wordt geadviseerd om contact op te nemen met buitenlandse organismen of met Sigedis *4*. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor de grensoverschrijdende datastroom afgeschoven en blijft de burger verstoken van de noodzakelijke bevestiging dat zijn Belgische loopbaanjaren correct zijn geregistreerd voor de Nederlandse pensioenopbouw.

*1* Federale Pensioendienst, taken: toekenning en betaling van wettelijke pensioenen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.

*2* SFPD is belast met de toekenning van rustpensioen, overlevingspensioen, overgangsuitkering en inkomensgarantie voor ouderen.

*3* Entry 02-09-2026: AVG-inzageverzoek bij SFPD voor EESSI-logbestanden en BUC/SED-berichten.

*4* Entry 02-10-2026: reactie DPO SFPD: EESSI-gegevens bevinden zich niet in de systemen van de SFPD; verwijzing naar Sigedis of buitenlandse organismen.

# VERTICO BUSINESS SOLUTIONS

*De Normale Basis en het Contrast met de Overheid*

Om te begrijpen waar een systeem faalt, moet eerst worden vastgesteld hoe het eruitziet wanneer het wel werkt. In dit grensoverschrijdende dossier is de private werkgever, Vertico Business Solutions, de actor die de norm bepaalt. De arbeidsrelatie start hier in het voorjaar van 2025. Wanneer de medische noodsituatie in april van dat jaar toeslaat, voert het bedrijf simpelweg de wet uit. De loondoorbetaling tijdens de eerste dertig ziektedagen verloopt foutloos, gevolgd door een correcte en tijdige administratieve overgang naar de status van onbetaald ziekteverlof. De loonbrieven registreren keurig nul euro, waarmee de financiële overdracht naar de sociale zekerheid zuiver wordt voorbereid.

Wanneer het contract in september 2025 door de aanhoudende medische uitval formeel wordt beëindigd, levert het bedrijf direct de eindafrekening en de verplichte tewerkstellingsattesten af. Deze papieren zijn geen overbodige luxe; zij vormen de absolute juridische basis voor de latere opmaak van de Europese U1-formulieren *1*. Dit zijn de documenten die de werknemer nodig heeft om zijn arbeidsverleden en rechten in het buitenland te kunnen aantonen. De werkgever levert deze sleutels zonder enige vertraging of procedurele frictie af aan de werknemer.

De ware betekenis van deze organisatie in de systeem-audit ligt dan ook niet in een interne fout, maar in het schrille contrast met de publieke sector. De private werkgever bewijst dat de basisregels van de administratie eenvoudig en correct kunnen worden toegepast. Zij leveren de perfecte, foutloze data aan. De breuk in het systeem ontstaat pas op het exacte moment dat deze correcte papieren de private sector verlaten en worden ingediend bij de overheid. Zodra de Belgische en Nederlandse sociale zekerheidsinstanties de foutloze attesten in handen krijgen, loopt het proces direct vast in onverenigbare regels en datasilo's.

*1* Het Portable Document U1 (PD U1) is het standaard Europese formulier dat perioden van verzekering of werkzaamheden in een EU-lidstaat bevestigt, essentieel voor de berekening van werkloosheids- of ziekte-uitkeringen in een ander land.

# Escalatie & Controle

## CONTROLEDIENST VOOR DE ZIEKENFONDSEN (CDZ)

*De Waakhond die Weigert te Bijten*

Als het RIZIV faalt in haar regisseursrol, is er in de Belgische architectuur nog één gespecialiseerde toezichthouder: de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ). Deze administratieve waakhond heeft als kerntaak te controleren of ziekenfondsen de nationale wetten en Europese regels correct uitvoeren. Wanneer de CDZ in april 2026 formeel wordt aangeschreven over het feit dat de Christelijke Mutualiteit (CM) weigert het Europese Unierecht *1* toe te passen, demonstreert deze dienst echter de klassieke overheidstactiek van jurisdictionele zelfdefinitie.

De CDZ schuift de klacht onmiddellijk terzijde door zich onbevoegd te verklaren. Om deze weigering te legitimeren, gebruikt de toezichthouder een slimme administratieve truc: zij kwalificeert de structurele, grensoverschrijdende schending van Europese wetgeving door het ziekenfonds simpelweg als een 'individueel medisch geschil'. En omdat medische geschillen onder het RIZIV vallen, mag de CDZ het dossier officieel sluiten. Dit is een procedurele fout. De klacht ging immers niet over een medische diagnose — amputaties zijn een onbetwistbaar fysiek feit — maar over het doelbewust negeren van administratieve dwingende wetgeving door een uitvoeringsorgaan.

Wanneer de patiënt krachtig protesteert tegen deze onterechte doorverwijzing en de CDZ herinnert aan haar wettelijke toezichtsplicht, trekt de waakhond zich volledig terug. In opeenvolgende correspondentie handhaaft de dienst haar standpunt, beschouwt zij de klacht eenzijdig als afgehandeld en weigert zij elke verdere inhoudelijke communicatie. De CDZ bewijst hiermee dat er in het Belgische stelsel geen enkel functionerend administratief toezichtorgaan bestaat dat in staat is om de ziekenfondsen dwingend te corrigeren wanneer zij op individueel niveau de Europese rechtsorde schenden.

*1* Specifiek het weigeren van de samentelling van verzekeringstijdvakken onder Verordening (EG) 883/2004 en het negeren van vaststaande rechtspraak (Vester-arrest C-134/18).

# DE FEDERALE OMBUDSMAN

*De Gedesillusioneerde Bemiddelaar*

Binnen de escalatieladder van dit dossier is de Federale Ombudsman een uiterst zeldzame verschijning: het is de enige institutie die daadwerkelijk snelle en menselijke betrokkenheid toont. Wanneer deze parlementaire ombudsdienst in het voorjaar van 2026 wordt ingeschakeld, volgt er direct een inhoudelijke actie. De Ombudsman confronteert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) met de Europese regelgeving *1* rondom het woonplaatsvereiste, en forceert binnen enkele weken een doorbraak: de overheid moet toegeven dat een buitenlands adres geen medische beoordeling in de weg mag staan. Het dossier wordt heropend.

Deze kortstondige overwinning legt echter genadeloos de structurele beperkingen van een louter bemiddelende functie bloot. Zodra de FOD procedureel heeft gereageerd, beschouwt de Ombudsman zijn opdracht als volbracht en trekt hij zich terug uit de onderliggende financiële impasse bij de Christelijke Mutualiteit (CM). Omdat het ziekenfonds buiten de directe federale werkingssfeer valt, adviseert de Ombudsman de gedupeerde grensburger om het geschil dan maar voor de arbeidsrechtbank te brengen — een proces dat de patiënt financieel en fysiek niet kan dragen.

De ware tragedie van dit knooppunt ontvouwt zich echter in de zomer van 2026. Wanneer de burger aantoont dat zowel het RIZIV als de CDZ hun toezichtsplicht verzaken, en dat de interne ombudsdienst van het ziekenfonds aantoonbaar liegt over de medische bewijslast, activeert de Federale Ombudsman opnieuw een onderzoek. De attaché roept het weigerende ziekenfonds rechtstreeks ter verantwoording. Maar geconfronteerd met het taaie, onbeweeglijke administratieve verweer van de CM, capituleert de toezichthouder uiteindelijk.

In een houding die het best kan worden omschreven als een formele sluitingsreflex, sluit de Ombudsman het dossier definitief. Men wast de handen in onschuld door de administratieve fictie van het ziekenfonds klakkeloos te valideren. Ondanks de objectieve, academisch vastgestelde realiteit van amputaties en orgaanschade — fysieke toestanden die geen pauzeknop of tijdelijke genezing kennen — accepteert de Ombudsman het excuus dat er "medische hiaten" in het dossier zouden zitten. De meest competente en geëngageerde instantie binnen de Belgische landsgrenzen eindigt haar interventie zo in absolute apathie, de burger onbeschermd achterlatend op een administratief niemandsland.

*1* Verordening (EG) 883/2004 en de dwingende Europese jurisprudentie die lidstaten verbiedt burgers uit te sluiten op basis van territoriale grenzen.

## DE KAMER (COMMISSIE SOCIALE ZAKEN)

*De Zwijgende Volksvertegenwoordiging*

Wanneer administratieve toezichthouders weigeren in te grijpen, is het democratisch parlement de ultieme verdedigingslinie. Binnen de Belgische Kamer is de Commissie Sociale Zaken, Werk en Pensioenen specifiek bevoegd om ministers en overheidsdiensten (zoals het RIZIV en de FOD Sociale Zekerheid) te controleren en ter verantwoording te roepen. In het voorjaar van 2026 wordt deze commissie formeel voorzien van een uitgebreid, objectief dossier dat aantoont hoe uitvoeringsinstanties de Europese regels voor grensarbeiders structureel negeren en burgers in de financiële afgrond duwen.

De reactie van dit parlementaire controleorgaan is echter veelzeggend: een absolute radiostilte. De commissie ontvangt de data, maar er volgt geen enkele inhoudelijke respons. Geen enkel parlementslid activeert zijn of haar controlemandaat. Er worden geen kritische vragen gesteld aan de bevoegde minister, er wordt geen interpellatie gehouden en er volgt geen hoorzitting over het grensoverschrijdende bevoegdheidsvacuüm.

Deze totale afwezigheid van democratisch toezicht illustreert een diepgeworteld systeemfalen. De instantie die wettelijk is opgericht om de uitvoerende macht te controleren wanneer deze tekortschiet, weigert de aangeleverde bewijslast te behandelen. Door simpelweg te zwijgen, legitimeert de volksvertegenwoordiging de handelingen van de administratie en laat zij de burger — die als eenling tegen een georganiseerde staat vecht — definitief in de kou staan.

# COMMISSIE VOOR VERZOEKSCHRIFTEN

*De Doorgeefluik-Democratie*

Waar de Commissie Sociale Zaken reageert met stilzwijgen, biedt de Commissie voor Verzoekschriften de formele 'klaagmuur' van de democratie. Hier kan de burger rechtstreeks petities indienen over falend overheidsbeleid. In het voorjaar van 2026 wordt de Systeem-Audit als formeel verzoekschrift ingediend, ter aanklacht tegen de administratieve blokkade en de schending van het Europese recht *1* door Belgische instellingen.

De procedurele molen draait aanvankelijk volgens het boekje. Na een initiële afwijzing door de Kamervoorzitter, gebaseerd op de strikte scheiding der machten, wordt de kwantitatieve audit-data toch formeel ontvankelijk verklaard. Het dossier krijgt een officieel nummer en wordt meegenomen in de parlementaire processen. De afhandeling die daarop volgt, demonstreert echter pijnlijk hoe procedureel 'afvinken' in de praktijk werkt.

In juni 2026 besluit de commissie het dossier eenvoudigweg door te zenden naar de bevoegde minister en de vakcommissie (Sociale Zaken). Met deze simpele administratieve handeling beschouwt de Commissie voor Verzoekschriften haar taak als volbracht. De hete aardappel is doorgegeven. Omdat de ontvangende partijen (de minister en de vakcommissie) het dossier vervolgens zonder inhoudelijke actie laten doodbloeden, fungeert het verzoekschriften-kanaal in de praktijk als niets meer dan een procedurele schokdemper: het absorbeert de klacht van de burger, zet er een stempel op, en parkeert het in een laag waar niemand er politieke verantwoordelijkheid voor neemt.

*1* Verordening (EG) 883/2004 en de principes van vrij verkeer van werknemers, waarbij burgers over de grens naadloze toegang moeten hebben tot sociale zekerheid.

# ARBEIDSAUDITORAAT GENT

*De Falende Noodrem en het Afschuiven van Toezicht*

Wanneer een machtige uitvoeringsinstantie zoals het ziekenfonds de wet systematisch weigert toe te passen, zou de rechtsstaat een snelle noodrem moeten hebben. Binnen de Belgische sociale zekerheid is die toezichthoudende rol in theorie weggelegd voor het sociaal parket: het Arbeidsauditoraat. Na maanden van administratieve blokkade door de mutualiteit escaleert de grensarbeider het dossier in het najaar van 2026 naar deze justitiële waakhond. De formele melding bevat sluitende bewijzen dat het ziekenfonds structureel de Europese regels voor de optelling van gewerkte jaren negeert *1* en de eigen nationale richtlijnen aan de kant schuift.

De reactie van het Arbeidsauditoraat legt echter een diepe weeffout in het toezicht bloot. In plaats van in te grijpen bij een instantie die de Europese wetgeving naast zich neerlegt, wast het parket zijn handen in onschuld. Het auditoraat verklaart zich per kerende e-mail simpelweg onbevoegd om toezicht te houden op de handelingen van de ziekenfondsen of de federale gezondheidsinstituten.

Hier toont zich de tactiek van het bevoegdheidsvacuüm. Het justitiële systeem weigert de situatie te zien als een structureel probleem van institutioneel falen of machtsmisbruik. In plaats daarvan wordt de weigering van de mutualiteit gekwalificeerd als een simpel burgerlijk geschil tussen een ontevreden klant en een verzekeraar. Het auditoraat schuift de volledige verantwoordelijkheid daardoor genadeloos terug naar de burger, met de formele mededeling dat hij de zaak maar voor de Arbeidsrechtbank moet uitvechten.

Hierdoor faalt het vangnet compleet: de structurele systeemfout wordt niet op een hoger, overkoepelend niveau opgelost, maar wordt gereduceerd tot een traag en uitputtend individueel proces dat de patiënt helemaal zelf moet dragen. Het instituut dat is opgericht om de regels te bewaken, kiest voor de weg van de minste weerstand en trekt zich terug.

*1* De dwingende Europese regelgeving inzake de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (Verordening (EG) 883/2004), die voorschrijft dat lidstaten arbeidsverleden en sociale rechten over de landsgrenzen heen naadloos moeten erkennen.

## KONINKLIJK PALEIS VAN BELGIË

*De Symbolische Eindhalte*

Als alle bestuurlijke, toezichthoudende en democratische paden doodlopen, rest er symbolisch nog één instantie: het staatshoofd. In mei 2026 wordt de geconsolideerde Systeem-Audit als formeel verzoekschrift naar het Koninklijk Paleis in Brussel gestuurd. Dit moment legt onbedoeld de letterlijke en figuurlijke onbereikbaarheid van het instituut bloot. Pogingen om het dossier via de officiële digitale kanalen van de monarchie aan te leveren verlopen moeizaam: de website functioneert op dat moment niet naar behoren. De aanvrager kiest daarom voor aangetekende post in het Frans, de klassieke weg voor een verzoekschrift aan het staatshoofd.

Wanneer de fysieke brief het Paleis bereikt, toont de afhandeling direct de grenzen van de constitutionele monarchie. Hoewel de Koning de eenheid van de staat vertegenwoordigt, heeft hij binnen een democratie absoluut geen uitvoerende macht om in te grijpen in het beleid van overheidsinstanties of ziekenfondsen. De reactie is dan ook een formele doorgeleiding: het Paleis bevestigt de ontvangst en stuurt het dossier rechtstreeks door naar de bevoegde bewindspersoon, de Vice-eersteminister.

Met deze handeling stopt de interventie. Het Paleis functioneert niet als een breekijzer, maar als de hoogste symbolische postbus van het land. Zodra het dossier wordt teruggestuurd naar het ministerie — exact de politieke laag die het probleem eerder al had genegeerd — is de escalatieladder van de staat definitief en volledig uitgeput, zonder dat er ook maar één stap richting een inhoudelijke oplossing is gezet.

# ORDE DER ARTSEN

*De Tuchtrechtelijke Grens en de Individuele Verantwoordelijkheid*

De Orde der Artsen is de wettelijke instantie die waakt over de medische deontologie, de ethiek en de professionele onafhankelijkheid van artsen in België. Haar tuchtrechtelijke bevoegdheid reikt uitsluitend tot het individuele handelen van de ingeschreven arts. De Orde heeft de macht om onafhankelijk onderzoek te voeren en kan tuchtsancties opleggen, variërend van een waarschuwing of berisping tot een schorsing of definitieve schrapping uit het artsenregister. De instantie heeft echter geen wettelijke bevoegdheid over de administratieve besluitvorming van instellingen zoals ziekenfondsen, noch over de geautomatiseerde IT-systemen en algoritmes die deze organisaties inzetten.

In het najaar van 2026 wordt de casus formeel bij deze tuchtraad aanhangig gemaakt. Het ingediende dossier bevat de documentatie van tegengestelde beslissingen, gegenereerd onder een visueel identieke handtekening van één adviserend arts van de Christelijke Mutualiteit (CM), waarbij objectief beschikbare medische data (SumEHR via eHealth) onbenut bleef. De formele onderzoeksvraag richt zich op de deontologische verantwoordelijkheid: in hoeverre kan een arts haar onafhankelijkheid bewaren wanneer beslissingen en handtekeningen geautomatiseerd door het systeem van de werkgever worden gegenereerd.

Deze tuchtrechtelijke route objectiveert een structurele asymmetrie in het medisch-administratieve toezicht. Omdat het mandaat van de Orde strikt beperkt is tot de individuele zorgverlener, dwingt het systeem de burger om de arts als uitsluitende verantwoordelijke aan te spreken. Hierbij ontstaat een juridische blinde vlek: de procedure toetst de arts, maar kan niet vaststellen in hoeverre de IT-architectuur van de CM de beslissingen in werkelijkheid autonoom stuurt. De arts wordt tuchtrechtelijk afgerekend op documenten waarop zij mogelijk enkel nog als een digitaal stempel fungeert.

De functionele limiet van dit escalatiekanaal manifesteert zich in de gevolgen van een mogelijke veroordeling. Zelfs indien de Provinciale Raad de klacht valideert en de betrokken arts sanctioneert, heeft deze uitspraak geen opschortende of corrigerende werking op de administratieve beslissing van het ziekenfonds ten aanzien van de patiënt. Het ziekenfonds behoudt zijn systeemarchitectuur en kan de gesanctioneerde arts procedureel vervangen door een andere adviserend arts. Deze opvolger wordt vervolgens in exact hetzelfde geautomatiseerde besluitvormingsproces ingeschakeld. De tuchtrechtelijke interventie treft hierdoor uitsluitend het individu en haar licentie, terwijl het achterliggende datanetwerk van de organisatie ongehinderd blijft functioneren.

# POLITIEKE PARTIJEN & FRACTIES

*De Uitzichtloze Beleidsmolen*

De cirkel van stilstand eindigt bij de enigen die daadwerkelijk de macht hebben om falende wetten te herschrijven: de politieke partijen en hun verkozen fracties. In april en juni 2026 wordt de Systeem-Audit verzonden naar de voorzitters en secretariaten van alle grote partijen in België. Wat volgt is een consequent patroon van politieke niet-inmenging. Het merendeel van de partijen (zoals Ecolo, MR, Vooruit en Open VLD) produceert helemaal geen antwoord en laat het dossier ongelezen achter in de politieke mailbox.

De partijen die wel reageren, bedienen zich van standaard protocollen om onmiddellijke actie te vermijden. Zo stelt de regeringspartij N-VA simpelweg geen individuele dossiers te kunnen beoordelen en verwijst zij de burger simpelweg terug naar de administratieve diensten die de klok rond precies de bron van het probleem zijn. Anderen, zoals de PS en de CD&V, tonen begrip of zelfs empathie voor de situatie, maar weigeren parlementaire instrumenten in te zetten. Zij schuiven het dossier stilletjes door naar hun eigen 'studiediensten'. Daar wordt de actuele noodsituatie van de burger omgevormd tot een abstract theoretisch knelpunt voor langetermijnbeleid.

Opvallend genoeg volgt de enige snelle, inhoudelijke en actiegerichte reactie niet vanuit het nationale partijhoofdkwartier, maar via het Europese kanaal van een aangeschreven Europarlementariër, die de weeffouten herkent en toezegt deze mee te nemen in de herziening van de Europese regels. De brede nationale politiek weigert echter categorisch om de acute systeemfout politiek te agenderen. Zij schrijven de wetten die de grensarbeider uitsluiten, maar zodra die burger aantoont dat de theorie in de praktijk levens verwoest, verbergen de wetgevers zich veilig achter de ondoorgrondelijke molens van hun eigen studiediensten.

# RIZIV

*De Ontwerper van de Cirkelredenering en het Toezichtsvacuüm*

Wanneer de uitvoerende instanties en het sociaal parket geen doorgang bieden, verschuift het administratieve traject naar de regisseur van het systeem: het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Deze federale overheidsdienst beheert de budgetten en bepaalt de regels waaraan ziekenfondsen zich dienen te houden. In het voorjaar van 2026 wordt de afdeling Internationale Zaken formeel aangeschreven met het verzoek de toepassing van de Europese regels voor grensarbeiders *1* te handhaven en de medische erkenning formeel los te koppelen van het recht op een financiële uitkering.

De schriftelijke reactie in mei 2026 bevestigt principieel dat een medische vaststelling wettelijk mogelijk is zonder dat daar een financiële uitkering aan gekoppeld is. Hiermee wordt het procedurele verweer van het ziekenfonds – dat deze koppeling dwingend zou zijn – feitelijk ontkracht. Desondanks weigert het instituut deze vaststelling om te zetten in een bindende correctie naar de uitvoerende instantie toe.

In plaats van sturend op te treden, verwijst de toezichthouder naar de eigen procedurele richtlijnen. Om de onafhankelijke Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) in te schakelen, dicteert de regelgeving dat de aanvraag verplicht via het ziekenfonds moet verlopen. Hiermee ontstaat een gesloten administratieve cirkel: de burger wordt verplicht de instantie in te schakelen die de procedure blokkeert, om de blokkade te laten onderzoeken. Het RIZIV gebruikt zijn bevoegdheid als beheerder van de ziekteverzekering niet om een weigerende instantie te passeren, waardoor de procedure feitelijk stagneert.

In september 2026 objectiveert de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van het RIZIV een bijkomend structureel falen binnen het netwerk. Uit een onafhankelijke raadpleging van het nationale EESSI-knooppunt *2* blijkt dat er in de voorafgaande zes maanden geen enkel elektronisch bericht inzake de verdragspolis of invaliditeit is uitgewisseld tussen het betrokken Belgische ziekenfonds en de Nederlandse instanties. Hoewel de toezichthouder hiermee het verzuim van de verplichte geautomatiseerde Europese gegevensuitwisseling *3* feitelijk vaststelt, beroept het RIZIV zich op een procedurele beperking: het DPO-Office doet formeel geen uitspraak over de inhoud van het dossier of over het uitblijven van specifieke berichten, omdat dit vragen over de inhoud van het dossier zouden zijn. De instantie registreert de radiostilte, maar acht zich niet inhoudelijk bevoegd om daar toezichthoudende conclusies aan te verbinden. Het gevolg is dat de feitelijke vaststelling in het lucht blijft hangen: geen handhaving, geen correctie, geen doorwerking naar het ziekenfonds dat de berichten niet verstuurt. Hierdoor blijft de burger genoodzaakt de transnationale gegevensstroom handmatig te faciliteren.

*1* Verordening (EG) 883/2004 en de dwingende jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie (waaronder het Vester-arrest C-134/18), die de coördinatie van socialezekerheidsstelsels en de naadloze samentelling van verzekeringstijdvakken voorschrijven.

*2* Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), het beveiligde Europese IT-netwerk voor de geautomatiseerde uitwisseling van gestructureerde elektronische documenten (SED's) tussen nationale instanties.

*3* Uitvoeringsverordening (EG) 987/2009, die de verplichte en onverwijlde elektronische uitwisseling van gegevens (via EESSI) tussen de bevoegde organen van de lidstaten wettelijk verankert.

## UNIA

*De Geketende Waakhond en Gelegaliseerde Discriminatie*

Wanneer uitvoerende instanties een burger bewust uitsluiten op basis van zijn woonplaats in een buurland, rijst onmiddellijk de vraag naar discriminatie. In België is UNIA (het Interfederaal Gelijkekansencentrum) de onafhankelijke waakhond die zulke situaties moet onderzoeken. In april 2026 ontvangt deze instantie de volledige dossieropbouw rondom de uitsluiting van de grensarbeider, waarbij de weigering van medische erkenningen puur vanwege een Nederlands domicilie wordt aangekaart.

De beoordeling door UNIA ontmaskert echter een tekort in de Belgische antidiscriminatiewetgeving. De waakhond verklaart zich namelijk formeel onbevoegd, en wel om twee dodelijke redenen. Ten eerste: in de wet is 'woonplaats' simpelweg geen beschermd criterium. Men mag een burger dus probleemloos anders behandelen of uitsluiten puur omdat hij net over de grens slaapt. Ten tweede, en nog veel fundamenteler: UNIA mag geen actie ondernemen als de uitsluiting direct voortvloeit uit een wet of een decreet.

Dit is de ultieme paradox van institutionele rechtvaardigheid: als een ambtenaar discrimineert, kan de waakhond ingrijpen, maar als de wet zelf discrimineert, is de waakhond machteloos. De enige instantie die discriminerende wetten mag toetsen en vernietigen is het Grondwettelijk Hof. Voor de burger betekent dit een situatie zonder uitweg, want dit Hof is alleen toegankelijk via loodzware en kostbare juridische rechtszaken. UNIA sluit het dossier, en bevestigt daarmee ongewild dat structurele uitsluiting van grensarbeiders binnen het huidige systeem volkomen gelegaliseerd is.

# II. Nederland

## Zorg & Verzekering

### CAK

*De Ontbrekende Categorie in de Databank*

Het falen van CZ bij het doorgeven van de verdragspolis vindt zijn oorzaak bij de ontvangende partij: het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze Nederlandse overheidsinstantie is de landelijke beheerder van het verzekeringsregister. Dit register fungeert als de absolute waarheid voor de Belastingdienst: wie hier niet als verzekerd staat aangemerkt, krijgt geen zorgtoeslag. Wanneer de burger in april 2026 formeel eist dat zijn actieve en betaalde verdragspolis in deze databank wordt bijgeschreven, legt het CAK een fundamentele architectuurfout in de eigen systemen bloot.

De instantie weigert de polis te registreren met een uiterst procedureel argument. Het CAK stelt dat zij uitsluitend de 'standaard' grensarbeider registreren: de persoon die in Nederland werkt en in het buitenland woont. Voor de omgekeerde situatie — wonen in Nederland, werken in het buitenland — is er simpelweg geen categorie in het systeem geprogrammeerd. De wet staat het toe, het verdrag regelt het, maar de computer kent het formulierveld niet.

In plaats van deze administratieve fout te herstellen en de Europese burgerrechten te borgen, kiest de overheidsdienst voor de eenvoudigste weg: men sluit het dossier en weigert verdere actie. Door het ontbreken van één digitaal label wordt een inwoner van Nederland door de eigen overheid structureel als 'onverzekerd' bestempeld, waardoor financiële tegemoetkomingen op de nul-stand worden bevroren.

# CZ

*De Verdragspolis en Incompatibele Protocollen*

Voor een inwoner van Nederland die in België werkt, verloopt de ziektekostendekking via een zogenaamde verdragspolis *1*, in dit dossier uitgevoerd door verzekeraar CZ. Deze instantie bevindt zich direct op het kruispunt van twee nationale systemen en illustreert de striktheid van protocollen. CZ vergoedt de fysieke medische rekeningen van zowel de Belgische ziekenhuizen als de Nederlandse thuiszorg probleemloos. De frictie ontstaat pas wanneer er logistieke ondersteuning nodig is in de vorm van zittend ziekenvervoer.

Ondanks de objectief vastgestelde amputaties en het kritieke visusverlies, wijst CZ het medisch transport af. De verzekeraar baseert deze afwijzing op één ontbrekend controlevinkje: een gezichtsveldonderzoek. Het probleem is dat dit specifieke onderzoek binnen de klinische protocollen van het Belgische ziekenhuis bij deze aandoening helemaal niet standaard wordt uitgevoerd. CZ eist dus een administratief bewijsstuk dat in het behandelende land niet bestaat. Zelfs wanneer de patiënt sluitende alternatieve bewijzen uit een universitair ziekenhuis overlegt en een beroep doet op de hardheidsclausule, weigert de verzekeraar af te wijken van zijn wiskundige rekenmethode. Het algoritme dicteert de uitkomst en de patiënt wordt letterlijk stilgezet.

Daarnaast blokkeert CZ de wettelijke zorgtoeslag via een bewuste juridische positie. De verzekeraar weigert de actieve verdragspolis te registreren in het landelijke Nederlandse verzekeringsregister *2*, met het formele argument dat een verdragspolis geen Nederlandse zorgverzekering is en er daarom wettelijk geen recht zou bestaan op zorgtoeslag (definitief standpunt 22 mei 2026, bevestigd via BBZ op 29 mei 2026). Het is geen technisch verzuim of databug, maar een weloverwogen uitsluitingsgrond. Het gevolg is dat de Nederlandse belastingdienst de burger als onverzekerd beschouwt, wat de wettelijke zorgtoeslag structureel op nul zet.

Op 22 september 2026 bevestigt CZ (Divisie Operations) met formele excuses voor de vertraging de ontvangst van het op 7 september 2026 ingediende inzageverzoek aan de Functionaris voor Gegevensbescherming. De instantie verklaart dat het verzoek in behandeling is genomen en zegt een inhoudelijke reactie toe binnen dertig dagen na de originele ontvangstdatum.

*1* Een polis gebaseerd op Europese afspraken waarbij de grensarbeider in het werkland premie betaalt, maar via een verdrag in het woonland aanspraak maakt op medische zorg.

*2* Het Referentiebestand Verzekerden Zorgverzekeringswet (RIV).

# ONAFHANKELIJKE EXPERTS (NL)

*Het Falen van de Private Uitwijkmogelijkheid*

De weigering van de reguliere Nederlandse huisartsenzorg dwingt de grensarbeider richting de private en semi-publieke keuringsmarkt. Nederlandse bedrijven en overheden vereisen geregeld onafhankelijke gezondheidsverklaringen. Zo eist de Nederlandse energieleverancier in het voorjaar van 2026 een lokaal medisch bewijs om de patiënt als 'medisch kwetsbare consument' te beschermen tegen afsluiting, en eist de uitkeringsinstantie een objectieve nulmeting van de fysieke belastbaarheid. Wanneer de burger in de lente van 2026 probeert deze bewijzen buiten de gesloten ziekenhuizen om te verzamelen, wordt de illusoire aard van het private alternatief snel duidelijk.

Elke aangeschreven instantie sluit de deur met een ander excuus. De GGD, de publieke gezondheidsdienst van de regio, weigert particuliere verzoeken en verwijst door naar een huisarts, wetende dat diezelfde huisarts de patiënt zojuist heeft geweigerd wegens de dubbele-inschrijvingswet. Commerciële keuringsartsen en gespecialiseerde instituten blijken al even ontoegankelijk. De markt opereert als een los zand van private silo's, zonder enige verbinding met de Europese of nationale patiëntendossiers.

De ultieme belemmering openbaart zich echter in het kostenplaatje. De enkele onafhankelijke expert die wél bereid is om een grensoverschrijdend, complex medisch profiel te beoordelen, legt een offerte neer van meer dan tweeduizend euro. Dit bedrag wordt bovendien gevraagd voor een onderzoek dat louter via een videoverbinding zou plaatsvinden, zonder fysieke beoordeling van de amputatiewonden of het visusverlies. Dit objectiveert het failliet van de keuringsmarkt: het systeem dwingt de burger om een Nederlandse nulmeting aan te leveren ter voorkoming van financiële ruïnering, maar biedt uitsluitend uitwijkmogelijkheden die de financieel uitgeputte patiënt onmogelijk kan betalen.

# PALLION HUISARTSENPRAKTIJK

*De Wettelijke Grens van de Lokale Zorg*

Wanneer de patiënt beseft dat de Nederlandse overheidsinstanties structureel weigeren om de klinische documentatie van zijn Belgische huisarts te integreren, volgt in mei 2026 een logische tegenzet: de poging om een lokale medische achterwacht in het eigen woonland in te stellen. De patiënt dient een verzoek in bij een Nederlandse huisartsenpraktijk (Pallion) voor een zuiver informatieve inschrijving. Het doel is niet om de dagelijkse medische behandeling uit België weg te halen, maar louter om het complexe dossier te spiegelen in de Nederlandse zorgmatrix, zodat uitkerende en commerciële instanties de diagnoses kunnen verifiëren via een binnenlandse bron.

De aanvraag stuit echter onmiddellijk op een harde juridische grens. De Nederlandse Zorgverzekeringswet en de administratieve reglementen van de huisartsenzorg verbieden een dubbele inschrijving over de landsgrenzen heen. Een huisarts mag een burger alleen inschrijven als hij ook daadwerkelijk de primaire en actieve medische verantwoordelijkheid draagt. Het concept van een 'administratieve medische back-up' bestaat juridisch niet.

Deze formele afwijzing illustreert de starheid van de natiestaat. De theorie van het vrije verkeer in de grensstreek botst frontaal op systemen die exclusiviteit eisen. Doordat een administratieve koppeling onmogelijk is, wordt de patiënt in zijn eigen land medisch onzichtbaar gehouden. Hij heeft in zijn woonland geen enkele lokale zorgverlener die zijn dossier kent of zijn toestand officieel kan vertalen voor Nederlandse instanties, waardoor de papieren muur rondom zijn uitkeringen en sociale rechten ondoorbreekbaar blijft.

## ZORGINSTITUUT NEDERLAND (ZIN)

*De Gesloten Driehoek*

Wanneer een burger vastloopt tussen een weigerende verzekeraar (CZ) en een gebrekkige overheidsdatabank (CAK), schrijft de logica voor dat men zich wendt tot de toezichthouder. In Nederland is het Zorginstituut Nederland (ZIN) de waakhond die toezicht houdt op de correcte uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de datastromen daarbinnen. In april 2026 wordt dit instituut aangeschreven met het dwingende verzoek om de uitsluiting in het verzekeringsregister te onderzoeken en te corrigeren.

Het antwoord van het Zorginstituut voltooit echter de vicieuze cirkel. De instantie die wettelijk is belast met het beheer van het register, verklaart dat zij vanwege privacy- en bevoegdheidsregels geen inzage mag nemen in individuele dossiers. Zij weigert het systeem te controleren en geeft de burger het formele advies om dit probleem maar op te lossen met CZ en het CAK.

Hiermee is de driehoek volledig en potdicht gesloten. De verzekeraar wijst naar het systeem, de registerbeheerder zegt dat het systeem de patiënt niet kent, en de toezichthouder weigert in het systeem te kijken en verwijst terug naar de eerste twee. Geen enkele actor binnen deze keten neemt eigenaarschap over de uitkomst. Het resultaat is een perfecte, geautomatiseerde stilstand waarbij de burger als enige de financiële consequenties draagt.

# ZORGSAAM

*De Fysieke Zorg en de Onzichtbare Data*

De Nederlandse thuiszorgorganisatie ZorgSaam illustreert feilloos de breuklijn tussen fysieke medische handelingen en de digitalisering daarvan. Na het ontslag uit het Belgische ziekenhuis in mei 2025 levert deze instantie maandenlang de noodzakelijke, complexe wondzorg voor de amputaties aan huis. Deze zorg wordt methodisch gedocumenteerd: het interne cliëntenportaal registreert meer dan honderdtwintig klinische verslagen van Nederlandse zorgverleners over de zware fysieke toestand van de patiënt. Dit bewijst dat de medische realiteit op Nederlands grondgebied onweerlegbaar is vastgesteld.

Toch is deze schat aan informatie volstrekt nutteloos voor de rest van de overheid. De systemen van ZorgSaam zijn niet gekoppeld aan de Belgische ziekenhuizen, noch aan Nederlandse uitkeringsinstanties. Wanneer de Nederlandse arbeidsongeschiktheidsinstantie (UWV) de exacte ziektedatum betwist, stroomt de data van de eigen Nederlandse thuiszorg niet automatisch door om dit te corrigeren. De data bestaat, maar de overheid kan (of wil) er niet bij.

Deze isolatie bereikt een dieptepunt wanneer de patiënt besluit om zélf als data-koerier te fungeren. Om de behandelende Nederlandse verpleegkundigen inzicht te geven in de Belgische ziekenhuisgeschiedenis, uploadt hij in het voorjaar van 2026 handmatig de complete medische dossiers in het Nederlandse portaal. ZorgSaam ontvangt de data, maar de software weigert deze te integreren in de gestructureerde medische velden. De zware diagnoses — zoals amputaties en weefselafbraak — worden door het systeem simpelweg weggestopt onder een onopvallend tabblad 'Multimedia'. Hierdoor blijft de werkelijke medische geschiedenis voor elke meekijkende arts of keuringsinstantie verborgen achter een digitale dode hoek.

# Financiën & Sociale Zekerheid

## BELASTINGDIENST

*Het Digitale Doolhof en de Toeslagenval*

De Belastingdienst en de daaraan gekoppelde Dienst Toeslagen vormen in theorie het sociale vangnet van de Nederlandse staat, maar in de praktijk blijken zij een feitelijke fuik voor grensarbeiders. Het online aangifteportaal is uitsluitend ingericht op een huishouden met een stabiel, binnenlands belastbaar inkomen. Zodra een grensarbeider met uitsluitend een buitenlands inkomen en een plotselinge medische uitval de gegevens probeert in te voeren, produceert het systeem een vastgelopen nulresultaat. Het noodzakelijke toetsingsinkomen voor toeslagen kan hierdoor niet berekend worden.

Dit vertaalt zich direct in een vicieuze cirkel van financiële onteigening. Omdat het CAK weigert de verdragspolis te registreren, weigert de Dienst Toeslagen om de zorgtoeslag uit te keren; deze wordt structureel op nul euro gezet. Het kindgebonden budget valt aanvankelijk weg door de ontbrekende SVB-koppeling, maar wordt op 22 mei 2026 alsnog toegekend (€ 1.415 voor 2026 en € 739 nabetaling voor eind 2025) nadat de SVB-koppeling is geactiveerd. De huurtoeslag werkt deels (€ 1.401), met een verrekening van € 526,00 op een openstaande schuld uit 2025, waardoor een resterend saldo van € 912,00 blijft. De zorgtoeslag blijft bevroren op € 0 door de RIV-blokkade; tegen die blokkade loopt sinds 31 augustus 2026 een formeel herzieningsverzoek bij Dienst Toeslagen (kenmerk TL080 08B R) op basis van het betaalde Nederlandse eigen risico (€ 57,07) bij CZ. De burger wordt zo geconfronteerd met het stopzetten van vitale inkomensondersteuning, terwijl de oorzaak volledig ligt bij administratieve fouten en ontbrekende vinkjes in de registers van andere overheden.

Wanneer de patiënt om uitstel vraagt voor de inkomstenbelasting omdat de noodzakelijke buitenlandse attesten ontbreken, erkent de fiscus indirect de chaos door dit uitstel te verlenen. Toch blijft de geautomatiseerde incasso- en verrekeningsmachine onverminderd doorraten. Eerdere (onterecht uitgekeerde) toeslagen worden met harde hand ingehouden op openstaande bedragen, en bezwaarschriften worden stelselmatig ongegrond verklaard met als argument dat het toetsingsinkomen niet klopt — een afwijking die het direct gevolg is van het feit dat het eigen systeem geen raad weet met de grensoverschrijdende realiteit. Als ultieme tegenreactie dwingt de burger via de privacywetgeving volledige transparantie af over de geautomatiseerde internationale gegevensuitwisseling via de Europese infrastructuur.*1*

*1* Verzoek ingediend op grond van Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gericht op de logbestanden van de Europese DAC-infrastructuur (Directive on Administrative Cooperation).

## ENERGIEDIRECT

*De Overdracht Zonder Continuïteit*

De overstap van Vattenfall naar Energiedirect op 1 oktober 2026 is op het eerste gezicht een routineuze commerciële wissel. De consument kiest een nieuwe leverancier, de netbeheerder wikkelt de technische overdracht af, en de maandelijkse facturatie loopt door bij een nieuwe afzender. Wat deze gebeurtenis echter blootlegt, is een fundamentele systeemfout: er bestaat geen mechanisme om een lopend administratief dossier mee te laten verhuizen. De nieuwe leverancier start met een schone lei, terwijl de consument een verleden meesleept waar de nieuwe partij geen weet van heeft.

In het geval van de grensarbeider betekent dit dat de status van 'medisch kwetsbare consument', die bij Vattenfall maandenlang moeizaam werd opgebouwd, volledig verdampt bij de overdracht. Er is geen verplichte overdracht van dat dossier tussen commerciële energieleveranciers. Er is geen centraal register waarin een beschermingsstatus wordt bijgehouden die losstaat van de leverancier. De burger moet bij elke nieuwe leverancier opnieuw beginnen: dezelfde gezondheidsverklaring, dezelfde medische argumentatie, dezelfde rondgang langs instanties die geen van alle verplicht zijn om eerdere beslissingen over te nemen.

Dit mechanisme is geen incident, maar een structureel kenmerk van de private nutsmarkt. Waar de overheid bij een adreswijziging de Basisregistratie Personen automatisch bijwerkt, waar een ziekenhuis bij overdracht een digitaal dossier meestuurt, en waar zelfs de Belastingdienst bij verhuizing automatisch de gemeente op de hoogte stelt, geldt in de energiesector het omgekeerde principe: elke leverancier is een eiland. De netbeheerder Stedin fungeert uitsluitend als technisch doorgeefluik voor de fysieke aansluiting; er is geen enkele partij die de administratieve geschiedenis overdraagt.

Voor een grensarbeider met een complexe medische achtergrond wordt dit een terugkerende beproeving. Elke keer dat een commercieel contract verloopt, elke keer dat een leverancier fuseert of zijn naam wijzigt, en elke keer dat de consument besluit over te stappen, begint de administratieve bewijslast opnieuw. De medisch-kwetsbare status is geen recht dat de burger toekomt, maar een gunst die per commerciële relatie moet worden bevochten. Dit legt een fundamentele asymmetrie bloot tussen de fysieke werkelijkheid — de insuline die gekoeld moet blijven, ongeacht wie de energierekening verstuurt — en de administratieve werkelijkheid van losse leverancierssystemen die geen onderlinge geschiedenis delen.

De overstap naar Energiedirect is daarmee niet zozeer een nieuwe fase in het dossier, als wel een terugkeer naar het startpunt. De vraag of het lopende betalingsdossier en de medisch-kwetsbare status worden overgedragen, is op het moment van deze audit nog niet beantwoord. Wat vaststaat, is dat er geen systeem bestaat dat dit automatisch regelt. De burger moet het zelf opnieuw aanvragen, en de leverancier heeft geen enkele verplichting om de voorgeschiedenis te erkennen.

# GEMEENTE HULST & HULST VOOR ELKAAR

*De Digitale Muur en de GPK-Weigering*

Als lokaal overheidsorgaan zou de Gemeente Hulst (in de praktijk uitgevoerd door stichting Hulst voor Elkaar) het dichtst bij de burger moeten staan. In de feitelijke praktijk functioneert dit lokale bestuur echter als een ondoordringbare vesting. Gedurende het volledige traject stuit de communicatie op een actieve, technische muur. E-mails en formele AVG-inzageverzoeken gericht aan het bestuur of de functionaris gegevensbescherming verlopen moeizaam. Persoonlijke adressen binnen het gemeentedomein zijn niet rechtstreeks bereikbaar; alleen de algemene info-adressen staan open voor inkomende correspondentie. Berichten die via de persoonlijke adressen worden verzonden, expireren zonder inhoudelijke behandeling. Zodra een verzoek echter via de algemene kanalen binnenkomt, wordt het wel degelijk in behandeling genomen: op het AVG-inzageverzoek van 2 september 2026 volgt een verzoek tot nadere specificatie (10 september), een opschorting van de beslistermijn wegens ontbrekende identiteitsverificatie (1 oktober) en een deels toegekende, deels afgewezen beslissing (2 oktober). Het patroon is dus niet dat verzoeken categorisch worden genegeerd, maar dat ze alleen via de juiste kanalen kunnen doorkomen. Wanneer hulpverzoeken via e-loketten of formulieren binnenkomen, worden ze door de frontoffice na maanden van stilzwijgen simpelweg ongelezen uit de mailbox verwijderd.

Het meest treffende voorbeeld van de lokale afschuiving manifesteert zich rond de aanvraag van een Nederlandse Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) in de zomer van 2026. De grensarbeider beschikt over een officiële, permanente Europese parkeerkaart en een bindend medisch evaluatieverslag van de Belgische federale overheid (8 punten, erkende mobiliteitsbeperking). Omdat Nederlandse gemeenten steeds vaker digitaal op kenteken handhaven, vraagt de burger om een administratieve overname van deze status voor zijn auto met Nederlands kenteken, om onterechte boetes te voorkomen.

De gemeente Hulst weigert dit categorisch. Ondanks de overhandiging van officiële Europese overheidsdocumentatie, stelt de frontoffice dat deze onvoldoende zijn. De gemeente eist dat de burger zich onderwerpt aan een lokaal, door hen aangewezen medisch onderzoek, inclusief de betaling van bijbehorende leges. Hiermee negeert de gemeente de kern van de Europese wederzijdse erkenning. In een grensgemeente die volop meeprofiteert van Europese kaders, weigert men op lokaal niveau de geldigheid van een officieel EU-document te accepteren. Men eist een dubbele keuring, creëert daarmee onnodige financiële en administratieve frictie voor een gehandicapte grensarbeider, en legt de bestuurlijke paradox van de grensregio bloot in al haar facetten.

Op 21 september 2026 bevestigt de gemeente Hulst per formele brief (kenmerk 1064153) de ontvangst op 22 juli 2026 van het bezwaarschrift tegen de beschikking van 22 juni 2026 inzake de bijzondere bijstand. De gemeente verdaagt de beslissing op bezwaar op grond van artikel 7:10 lid 3 Awb met zes weken en verzoekt om retournering van het antwoordformulier horen vóór 30 september 2026. Betrokkene retourneert het formulier ondertekend op 24

september 2026 met de kennisgeving geen gebruik te maken van een mondelinge toelichting.

# ING NEDERLAND

*De Commerciële Redding en de Prijzige Schaduw*

Terwijl de overheid en de uitkeringsinstanties maandenlang weigeren om over de brug te komen met de wettelijk verschuldigde uitkeringen en toeslagen, tikt de dagelijkse economische realiteit door. Door het stilvallen van de inkomensstromen ontstaat er op de betaalrekening een gigantisch liquiditeitsprobleem, resulterend in een opgelopen roodstand en een torenhoge creditcardschuld. In het voorjaar van 2026 biedt de private huisbank, ING Nederland, hiervoor een even pragmatische als pijnlijke commerciële oplossing: de totale opgelopen schuldenlast wordt geparkeerd in een afzonderlijke betalingsregeling.

De bank toont zich hiermee flexibeler dan de gehele overheid bij elkaar. Er wordt een strak aflossingsplan van vierentwintig maanden opgesteld, waardoor een dreigend bankroet acuut wordt afgewend. Maar deze reddingsboei komt met een hard prijskaartje en strenge private sancties. De roodstandfaciliteit wordt per direct ingetrokken en het gebruik van de creditcard wordt voor lange tijd verboden. Als direct gevolg hiervan beginnen essentiële automatische incasso's — zoals de betaling aan het waterbedrijf — te mislukken, wat de dagelijkse huishoudelijke stress nog verder opvoert.

Dit knooppunt fungeert als de ultieme weerspiegeling van de maatschappelijke scheefstand. De commerciële bank lost het acute financiële brandje op dat door het tekortschieten van de overheid is ontstaan, maar zij incasseert daarvoor de rente en legt de burger zware sancties op. De overheidsinstanties die de administratieve crisis hebben veroorzaakt, dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de gemaakte bancaire kosten en verschuilen zich achter hun digitale loketten, terwijl de private bank de rol van de facto schuldeiser van de falende verzorgingsstaat overneemt.

## LEREN IN ZEELAND

*Het Jaarlijkse Bewijs van Buitenlandse Leerplicht*

Leren in Zeeland is het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Zeeuws-Vlaanderen, een samenwerkingsverband van de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen dat de Leerplichtwet 1969 uitvoert. Voor een kind dat in Nederland woont maar in België naar school gaat, geldt dat het niet in Nederland staat ingeschreven. De Leerplichtwet voorziet hierin via artikel 5 onder c: een jaarlijks aan te vragen vrijstelling van de inschrijvingsplicht, mits bewezen wordt dat het kind daadwerkelijk een onderwijsinstelling in het buitenland bezoekt.

Deze vrijstelling is in theorie een ruimhartige regeling. Zij erkent dat leerplicht niet betekent dat een kind fysiek in Nederland naar school moet, en zij opent de deur voor gezinnen die voor een school net over de grens kiezen. De praktijk is echter aanzienlijk stroperiger. De vrijstelling wordt voor één schooljaar verleend. Dat betekent dat de ouder elk jaar opnieuw een aanvraag moet indienen, met een door de buitenlandse school ingevuld, ondertekend en gestempeld attest als bijlage. Er is geen automatische verlenging, geen digitale koppeling, geen meerjarige status.

De fundamentele breuk in dit mechanisme is dat het RBL-systeem geen gegevens uitwisselt met de Belgische schooladministratie. Waar Nederlandse scholen via DUO elkaars inschrijvingen kunnen verifiëren, en waar de Basisregistratie Personen automatisch synchroniseert met gemeentelijke systemen, stopt de digitale infrastructuur bij de grens. Voor de Belgische school is er geen equivalent van DUO dat aansluiting zoekt met het Nederlandse leerplichtsysteem. Voor Leren in Zeeland is er geen bron om de inschrijving bij Berkenboom of eender welke Vlaamse school te verifiëren. De ouder is daarmee de enige schakel tussen twee systemen die elkaar niet kennen.

Dit vertaalt zich in een jaarlijks terugkerende administratieve handeling die volledig op handmatige bewijslast berust. De ouder moet het schoolattest opvragen, laten ondertekenen en stempelen, en vervolgens via de website van Leren in Zeeland uploaden. Er is geen categorie in het systeem die deze ouder als 'grensarbeider met kind in buitenland' markeert, waardoor het proces elk jaar opnieuw wordt doorlopen alsof het de eerste keer is. Er is geen uitzondering voor kinderen die meerdere jaren achter elkaar dezelfde Belgische school bezoeken. De wet schrijft voor dat de vrijstelling jaarlijks wordt verleend, en dus vraagt het systeem jaarlijks hetzelfde bewijs.

Wat dit mechanisme blootlegt, is hoe diep het binaire denken in nationale categorieën verankerd zit. De Leerplichtwet is geschreven voor een werkelijkheid waarin een kind óf in Nederland naar school gaat óf in het buitenland, en waarin het buitenland een uitzondering is die per geval bewezen moet worden. Voor een kind dat zijn hele schoolcarrière in België doorbrengt, is dit niet een uitzondering maar de normale situatie. Het systeem weigert deze realiteit te erkennen. Het blijft vragen om een jaarlijks bewijs van iets dat nooit verandert, omdat het geen categorie kent voor een leven dat structureel over de grens plaatsvindt.

# REIZEN DOOR ZEELAND

*Het Vervoersnetwerk*

Het collectieve Wmo-vervoer in de regio, uitgevoerd onder de naam Reizen door Zeeland, vormt de logistieke navelstreng voor een burger die door amputaties en visusverlies niet meer zelfstandig kan reizen. De praktijk van dit vervoerssysteem wordt gekenmerkt door strikte planningsregels met een selectieve uitzondering. Het lokale loket deelt al bij de eerste weigering op 9 maart 2026 mee dat de regiotaxi in principe niet over de grens rijdt, maar dat ritten naar Zeeland en naar het academisch ziekenhuis UZ Gent een uitzondering vormen. Die uitzondering geldt echter niet voor andere Belgische bestemmingen: een rit naar een Belgische overheidsinstantie (zoals de keuringsartsen van de FOD in Gent) op exact dezelfde afstand wordt geweigerd. Het systeem bepaalt waar een gehandicapte grensarbeider wel en niet mag komen.

Het onderscheid dat de centrale maakt, is even procedureel als belastend. Ritten naar een academisch ziekenhuis voor medische behandeling worden goedgekeurd, maar wanneer de burger een rit aanvraagt naar een officiële Belgische overheidsinstantie (zoals de keuringsartsen van de FOD) op exact dezelfde afstand, wordt de rit resoluut geweigerd. Het systeem dicteert waar een gehandicapte grensarbeider mag komen; medische noodzaak weegt minder zwaar dan de administratieve bestemming.

Daarnaast faalt de operationele uitvoering op elementaire onderdelen. Specifieke zorgvragen — zoals het verzoek om begeleiding van het voertuig naar de ziekenhuisingang bij ernstig visusverlies — worden door de planning consequent genegeerd en geregistreerd alsof het een valide reiziger betreft. Wanneer betalingsproblemen ontstaan door de algemene inkomensstagnatie, blokkeert de vervoerder bovendien per direct de Wmo-pas zonder enige coulance voor de specifieke betalingsritmes van grensarbeiders. De burger is zo voor zijn mobiliteit overgeleverd aan een weinig flexibel logistiek apparaat dat medische realiteit ondergeschikt maakt aan platte kilometerregels en planningsreglementen.

## RvIG

*De Beheerder van de Basisregistratie Personen en de Interstatelijke Datastroom*

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) is de landelijke beheerder van de Basisregistratie Personen (BRP) *1*. De dienst is verantwoordelijk voor de registratie en verstrekking van identiteitsgegevens aan Nederlandse overheidsinstanties, waaronder de Sociale Verzekeringsbank, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het Centraal Administratie Kantoor en de Belastingdienst *2*. Voor elke burger die in Nederland woont, fungeert het Burgerservicenummer (BSN) dat via de BRP wordt toegekend als de primaire sleutel voor alle administratieve processen. In het netwerk van de grensarbeider is RvIG daarmee de Nederlandse tegenhanger van het Belgische Rijksregister.

De frictie in dit dossier manifesteert zich op het snijvlak van twee nationale bevolkingsregisters. Wanneer een burger zich vanuit België in Nederland vestigt, is een geautomatiseerde overdracht van identiteitsgegevens tussen het Belgische Rijksregister en de Nederlandse BRP vereist. In de praktijk blijkt deze interstatelijke datalink echter niet automatisch te functioneren. De gemeente Hulst, als eerste inschrijvingsloket, voert de registratie uit, maar de koppeling met het Belgische bronregister verloopt manueel en niet-traceerbaar. De burger moet zelf aantonen welke gegevens zijn overgedragen en welke niet *3*.

Om deze lacune te onderzoeken dient de patiënt op 16 september 2026 een AVG-inzageverzoek in bij RvIG, gericht op de BRP-registratie en de bijbehorende internationale logbestanden uit 2014 *4*. Het verzoek betreft de elektronische mutaties, systeemstempels en metagegevens rondom de initiële inschrijving vanuit België. De eerste communicatie met de privacyjurist van RvIG verloopt moeizaam. De gemeente Hulst stelt dat de nationale doorgifte via de systemen van RvIG loopt en dat de gemeente niet over deze systeemstempels beschikt. RvIG bevestigt de formele ontvangst van het inzageverzoek, maar verschaft geen helderheid over de eigen rol in de interstatelijke datastroom *5*. Hierdoor ontstaat een bevoegdheidsvraag die dezelfde structuur vertoont als bij FOD IBZ aan Belgische zijde: geen van beide overheidsniveaus acht zich volledig verantwoordelijk voor de grensoverschrijdende datastroom.

Op 1 oktober 2026 bevestigt RvIG de formele ontvangst van het gecorrigeerde inzageverzoek en zegt een inhoudelijk besluit toe uiterlijk op 16 oktober 2026 *6*. De uitkomst van dat besluit is op het moment van deze audit nog niet bekend. Wat de casus echter al heeft blootgelegd, is structureel: er bestaat geen geautomatiseerde, traceerbare synchronisatie tussen de Belgische en Nederlandse bevolkingsregisters bij een grensoverschrijdende verhuizing. De burger blijft afhankelijk van handmatige procedures om zijn eigen registratiegegevens over de grens kloppend te houden.

*1* Rijksdienst voor Identiteitsgegevens: landelijke beheerder van de Basisregistratie Personen (BRP).

*2* RvIG verstrekt identiteitsgegevens aan Nederlandse overheidsinstanties; het Burgerservicenummer (BSN) wordt via de BRP toegekend.

*3* Entry 01-10-2026: de gemeente Hulst verwijst voor de internationale logbestanden naar RvIG; RvIG verwijst terug naar de gemeente als bronhouder.

*4* Entry 16-09-2026: indiening AVG-inzageverzoek BRP-registratie en internationale logbestanden 2014.

*5* Entry 01-10-2026: RvIG sluit de initiële melding af en bevestigt de ontvangst van het gecorrigeerde inzageverzoek.

*6* Besluittermijn: uiterlijk 16-10-2026.

## STEDIN

*De Netbeheerder en de Herstart van de Administratie*

Na de late en misleidende doorverwijzing door energieleverancier Vattenfall in de zomer van 2026, belandt het dossier over de bescherming van de medisch kwetsbare consument bij de regionale netbeheerder, Stedin. Omdat de netbeheerder in Nederland wettelijk verantwoordelijk is voor de fysieke leverings- en afsluitgarantie van het energienetwerk, is dit de enige partij die de stroomtoevoer voor de noodzakelijke koeling van de insuline daadwerkelijk kan waarborgen.

De overgang naar deze nieuwe instantie brengt echter een frustrerende administratieve realiteit met zich mee. Er bestaat geen enkele automatische datadoorgifte of communicatielijn tussen de energieleverancier en de netbeheerder. Dit betekent dat de patiënt de volledige, moeizaam opgebouwde medische bewijslast — inclusief de gezondheidsverklaring van de huisarts en het officiële Belgische evaluatierapport — opnieuw vanaf nul moet indienen bij een volledig nieuwe, private partij in de keten.

Dit knooppunt legt de versnippering van de private nutsector bloot. De burger wordt gedwongen om in een kwetsbare medische toestand een uitputtende rondgang langs verschillende commerciële loketten te maken, puur om een basisrecht op nutsvoorzieningen veilig te stellen. Elke nieuwe schakel in de keten vraagt om dezelfde bewijzen, verwerpt deze op basis van eigen protocollen, en laat de administratieve druk onverminderd op de schouders van de grensarbeider rusten.

# SVB & BBZ

*De Machteloze Bemiddelaar en Digitale Striktheid*

Binnen de Nederlandse overheid neemt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een dubbelrol in: het is de landelijke uitbetaler van gezinsbijslagen én het huisvest het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ), het specifieke kennis- en bemiddelingscentrum voor grensarbeiders. In het voorjaar van 2026 krijgt het uitbetalingsluik van de SVB de taak om de kinderbijslag recht te trekken. Omdat de partner in België werkt, wordt haar recht in Nederland afgewezen. De SVB verschuift dit recht succesvol naar de patiënt, een administratieve handeling die direct noodzakelijk is om de gekoppelde toeslagen bij de Belastingdienst te deblokkeren.

De communicatie met de SVB verloopt echter uiterst strikt. Wanneer de patiënt via laagdrempelige kanalen zoals WhatsApp om opheldering of statusupdates vraagt, weigeren de medewerkers inhoudelijk te helpen of de reeds geüploade digitale bewijsstukken te openen. Men dwingt de burger om zich aan de trage, gestandaardiseerde formulierstructuren van het webportaal te houden, een patroon dat zich maanden later herhaalt wanneer de instantie een rechtsgeldig per e-mail ingediend inzageverzoek *1* botweg weigert te behandelen tenzij het in hun eigen specifieke online formulier wordt gegoten.

De meest onthullende dynamiek speelt zich echter af bij het Bureau voor Belgische Zaken (BBZ). Wanneer de impasse tussen het UWV in Nederland en de Christelijke Mutualiteit (CM) in België rondom het Vester-arrest muurvast zit, stemt het BBZ in om formeel te bemiddelen. De adviseurs van de staat slagen erin om het Belgische RIZIV en het Nederlandse UWV voor het eerst in dit dossier met elkaar te laten praten. Even lijkt de overkoepelende, supranationale bemiddeling te werken.

De realiteit is echter genadeloos. Zodra het BBZ de uitvoerende instanties confronteert met de noodzaak tot ingrijpen, stuiten zij op exact dezelfde muren als de patiënt. Het ziekenfonds (CM) weigert uit te keren, het UWV weigert de uitkering aan te vullen, en verzekeraar CZ weigert de noodzakelijke registersynchronisatie uit te voeren. Het BBZ moet haar pogingen staken. Deze formele escalatie levert daardoor een vernietigend en onweerlegbaar bewijs op: zelfs een gespecialiseerd, door de staat gemandateerd bemiddelingsorgaan heeft absoluut geen bevoegdheid of macht om de eigen nationale uitvoeringsinstanties te dwingen de Europese regelgeving correct toe te passen.

*1* Verzoek onder Artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ter opvraging van de Europese logbestanden (EESSI) om de trage datastromen te kwantificeren.

# UWV

*De Datablokkade en de Weigering van het Unierecht*

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is in Nederland de poortwachter voor arbeidsongeschiktheid. Voor een grensarbeider is deze poort echter nagenoeg ondoordringbaar door een structurele weigering om buitenlandse data correct te verwerken. Dit begint al in het voorjaar van 2026 bij de vaststelling van de loopbaan. Hoewel het UWV het officiële Europese document ontvangt dat 21 jaar aan Belgische arbeidsgeschiedenis bewijst, negeert de instantie deze data volledig. Ze levert een document af waarop uitsluitend de zeer korte Nederlandse periode staat vermeld. Twee decennia aan sociale opbouw worden door het systeem simpelweg uitgewist, in directe strijd met de Europese beschermingsregels *1*.

Deze methodiek van uitsluiting zet zich voort in de medische beoordeling. Wanneer de burger een 'Beoordeling Arbeidsvermogen' aanvraagt, volgt een onmiddellijke administratieve afwijzing. De reden? Er ontbreekt een digitaal vinkje voor de inschrijving als 'werkzoekende'. Het systeem heeft geen logische categorie voor iemand die te ziek is om te werken, en blokkeert de medische keuring op een puur procedurele formaliteit.

De ware botsing met de realiteit ontstaat echter rond de ziektedatum. Het UWV hanteert strikt de datum van 11 mei 2025 als eerste ziektedag, en baseert daar de weigering van de WIA-uitkering op. De patiënt levert 700 gram aan medische dossiers aan, inclusief een sluitende Nederlandse thuiszorgrapportage, die onomstotelijk bewijzen dat de acute ziekenhuisopname en de amputaties al op 11 april 2025 plaatsvonden. Het UWV negeert deze harde bewijslast. In de bezwaarprocedure wordt de medische situatie simpelweg buiten beschouwing gelaten; de instantie klampt zich vast aan de eigen foutieve startdatum om niet inhoudelijk te hoeven oordelen.

Het ultieme breekpunt is de openlijke weigering om de dwingende Europese rechtspraak toe te passen. De patiënt beroept zich op het Vester-arrest *2* om de wachttijd voor een uitkering te doorbreken door de Belgische en Nederlandse verzekeringstijdvakken samen te tellen. Het UWV wijst dit expliciet af. Zij stellen dat zij dit recht pas toepassen als er éérst een formele beslissing uit België ligt. Omdat de Belgische instanties de beslissing eveneens blokkeren, creëert het UWV een moedwillige gesloten cirkel over de landsgrenzen heen. De instantie weigert elke constructieve oplossing en verwijst de financieel uitgeputte burger direct door naar de rechtbank.

Op 20 augustus 2026 dient de patiënt een herzieningsverzoek in op grond van artikel 4:6 Awb (zaak A29051942-01), gebaseerd op het nieuwe feit: het Belgische FOD-besluit van 3 augustus 2026. Op 1 september 2026 volgt een ontvangstbevestiging van UWV Breda (zaak A29172499-01) voor dit herzieningsverzoek. Tegelijk wordt de fysieke double-tap-brief met volledige kopie van het legitimatiebewijs per post verzonden voor het AVG-inzageverzoek op de EESSI-logbestanden.

*1* Conform het Casteels-arrest en Verordening (EG) 883/2004, die verbieden dat grensarbeiders hun opgebouwde rechten verliezen bij het wisselen van lidstaat.

*2* Arrest C-134/18 van het Europese Hof van Justitie, dat stelt dat lidstaten in situaties van opeenvolgende verzekeringen rekening moeten houden met tijdvakken in andere lidstaten om te voorkomen dat de werknemer tussen wal en schip valt.

# VALYS

*Bovenregionaal Sociaal-Recreatief Vervoer en Logistieke Ketenfrictie*

Valys is het landelijke vervoerssysteem dat in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het bovenregionale sociaal-recreatieve vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking faciliteert *1*. De organisatie verzorgt uitsluitend ritten die de grens van vijf openbaarvervoerzones vanaf het woonadres overschrijden, en opereert daarmee aanvullend op het gemeentelijke Wmo-vervoer *2*. Het systeem werkt met een persoonlijk kilometerbudget en is ingericht op het combineren van reizigersstromen om operationele efficiëntie te behalen.

In het dossier van de grensarbeider wordt Valys in september 2026 ingeschakeld voor een Valyspas. De aanvraag wordt op 27 september 2026 ontvangen en op 28 september 2026 goedgekeurd *3*. De persoonlijke pas wordt op 30 september 2026 per post geleverd. Vanaf dat moment krijgt de patiënt toegang tot bovenregionaal vervoer. De eerste feitelijke ritten zijn op het moment van deze audit nog niet geboekt; de werkelijke werking van het systeem in de praktijk is nog niet beproefd. Wat wel vaststaat, is de structurele opzet: Valys is een deelsysteem naast het lokale Wmo-vervoer en het reguliere treinverkeer, met eigen parameters en zonder overkoepelende regie over de keten. Of dat in de praktijk tot frictie leidt bij ketenreizen met overdrachten, moet de komende maanden blijken.

*1* *1* Ministerie van VWS, taakomschrijving Valys: landelijk bovenregionaal sociaal-recreatief vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking.

*2* *2* Valys is bedoeld voor reizen die meer dan vijf openbaarvervoerzones vanaf het woonadres liggen; het mandaat begint waar de gemeentelijke Wmo-plicht eindigt.

*3* *3* Entry 27-09-2026: ontvangstbevestiging aanvraag Valyspas; entry 28-09-2026: goedkeuring aanvraag Valyspas.

*4* *4* Structurele ketenfrictie: overdrachtsproblematiek tussen Valys en andere vervoerssystemen leidt tot wachttijden en communicatie-uitval.

# VATTENFALL

*De Commerciële Energie-Fuik en de Onuitvoerbare Medische Eisen*

De huishoudelijke impact van de grensoverschrijdende inkomensstagnatie kristalliseert zich pijnlijk uit in de relatie met de energieleverancier, Vattenfall. Door het uitblijven van wettelijke toeslagen en uitkeringen ontstaat er in 2025 en 2026 een aanhoudende betalingsachterstand op de energierekening van het huishouden. Hoewel er herhaaldelijk pogingen worden gedaan om via betalingsregelingen de lasten te spreiden, leidt de combinatie van stijgende maandtermijnen en torenhoge jaarafrekeningen tot een onoverbrugbare schuldencrisis die oploopt tot ruim tweeduizend euro.

Wanneer de huishouding dreigt te worden afgesloten, vraagt de partner om de officiële beschermingsstatus van 'medisch kwetsbare consument' te activeren, aangezien de patiënt de energie direct nodig heeft voor de gekoelde opslag van levensreddende insuline. Vattenfall eist hiervoor echter een officiële gezondheidsverklaring van een onafhankelijke Nederlandse arts. Zoals eerder vastgesteld, is een dergelijke verklaring voor een grensarbeider met een Belgisch medisch dossier via de lokale reguliere zorg nagenoeg onmogelijk te verkrijgen. De leverancier legt daarmee een eis neer die feitelijk onuitvoerbaar is.

De communicatie ontaardt vervolgens in een langdurig, moeizaam administratief traject. Maandenlang laat Vattenfall de ingediende medische gezondheidsverklaring onbeantwoord, terwijl de geautomatiseerde incassomachine onverminderd doorraadt en incassokosten opstapelt. Pas na lang aandringen geeft de energieleverancier toe dat zij de verklaring onterecht hebben geëist, omdat zij als leverancier helemaal geen afsluitgarantie kunnen afgeven. Na deze administratieve desillusie wordt de openstaande vordering alsnog uit handen gegeven aan een incassobureau. De patiënt wordt zo geconfronteerd met commerciële sancties en oplopende incassokosten, puur doordat de leverancier verzuimt de eigen verantwoordelijkheden te kennen en weigert de buitenlandse medische realiteit te erkennen.

# Escalatie & Controle

## DE NATIONALE OMBUDSMAN (NL)

*De Formele Drempel van de Onafhankelijke Arbiter*

De Nationale Ombudsman is in het Nederlandse bestel de onafhankelijke instantie die klachten behandelt over het handelen van overheidsinstanties zoals het UWV, de SVB en de Belastingdienst. Wanneer de grensarbeider in het voorjaar van 2026 dit instituut inschakelt om de gestapelde administratieve blokkades en het uitblijven van toeslagen aan te kaarten, ontstaat al snel een herkenbaar patroon van procedurele afwijzing.

Hoewel de klacht onder een officieel zaaknummer wordt geregistreerd, stuit het onderzoek direct op institutionele limieten. De Ombudsman meldt openlijk te kampen met structurele capaciteitsproblemen en hanteert een onwrikbare regel: er wordt geen actieve tussenkomst gestart zolang er formele bezwaar- of beroepsprocedures bij de instanties zelf lopen. Omdat het dossier nu eenmaal uit openstaande juridische procedures bestaat, weigert de Ombudsman in te grijpen.

Het instituut adviseert de burger om eerst alle reguliere juridische wegen binnen de falende instanties volledig te doorlopen. Hiermee wordt de Ombudsman een verlengstuk van het vertragende systeem: de instantie die moet ingrijpen bij bestuurlijk falen, dwingt de burger om te wachten tot de administratieve molen zelf is uitgedraaid. Nadat herhaalde pogingen en aanvullende dossiers stranden op deze formele reflex, wordt het dossier definitief gesloten en uitsluitend nog geregistreerd als een passief 'signaal'.

# KONINKLIJK HUIS (NEDERLAND)

*Het Grondwettelijke Nulpunt*

De escalatieladder binnen de Nederlandse staat eindigt, evenals in België, bij het symbolische staatshoofd. In mei 2026 wordt de Systeem-Audit per aangetekende post aangeboden aan het Kabinet van de Koning. Dit verzoekschrift markeert het bereiken van de absolute top van de nationale staatsinrichting met de vraag om aandacht voor de onzichtbare administratieve armoede in de grensstreek.

De reactie van het Kabinet van de Koning in juli 2026 volgt de stricte kaders van de Nederlandse Grondwet. Er wordt erkend dat de Koning persoonlijk geen enkele bevoegdheid bezit om in te grijpen in administratieve beslissingen of om uitvoerende instanties te corrigeren. Het Paleis biedt aan om het verzoekschrift formeel door te geleiden naar de bevoegde minister of staatssecretaris, mits de burger exact specificeert voor welk specifiek deelprobleem steun wordt gevraagd.

Hiermee is ook in Nederland de nationale escalatieladder definitief uitgewerkt. Het hoogste staatshoofd kan niet meer doen dan de brief terugsturen naar precies dat ministerie dat verantwoordelijk is voor de gemaakte fouten. Dit onderstreept het fundamentele uitgangspunt van deze audit: er is binnen de nationale structuren van beide lidstaten geen enkele instantie meer over die een transnationaal bevoegdheidsvacuüm kan oplossen. De nationale staat houdt op met functioneren zodra de grens wordt overstoken.

# NEDERLANDSE POLITIEKE PARTIJEN

*De Standaardontkenning van de Wetgever*

De politieke fracties in de Tweede Kamer vormen de wetgevende macht en dragen de politieke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de sociale zekerheid. Vanaf april 2026 worden de leiderschappen en secretariaten van diverse Nederlandse partijen (waaronder PVV, VVD, BBB en NSC) geconfronteerd met gedetailleerde brandbrieven over het grensoverschrijdende bevoegdheidsvacuüm. De reacties van het politieke landschap kenmerken zich door een volstrekte afwezigheid van inhoudelijke actie.

De respons van regeringspartijen en gevestigde fracties (zoals de VVD) is even voorspelbaar als teleurstellend. Men laat per standaardbrief weten niet te kunnen ingrijpen in persoonlijke dossiers en adviseert de burger om hulp te zoeken bij de Nationale Ombudsman — dezelfde Ombudsman die de zaak op zijn beurt al heeft afgewezen. Partijen die zich profileren op 'bestaanszekerheid' (zoals NSC) of partijen die opkomen voor de regio (zoals de BBB) sturen het dossier na lang wachten intern door naar beleidsmedewerkers, waarna het in de parlementaire vergetelheid verdwijnt zonder dat er ook maar één Kamervraag wordt gesteld.

De politieke macht toont zich in dit dossier volkomen vervreemd van de uitvoeringswerkelijkheid. Partijen schrijven de wetten die de binaire kaders en de digitale valkuilen creëren, maar zodra een burger met keiharde cijfers en tijdlijnen bewijst dat die wetten levens ontwrichten, zwijgen de fracties in alle talen of verschuilen zij zich achter procedurele onbevoegdheid.

# TWEEDE KAMER (COMMISSIE SZW)

*Het Geparkeerde Parlementaire Signaal*

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer is het democratische orgaan dat de bewindspersonen controleert op de uitvoering van de sociale zekerheid. In april 2026 ontvangt deze commissie een dwingende brandbrief en de volledige Systeem-Audit, waarin wordt blootgelegd hoe de Nederlandse wetgeving en uitvoeringsinstanties (zoals het UWV en de SVB) falen in de bescherming van grensarbeiders.

De ambtelijke griffie registreert de brief correct als een ingekomen stuk. Vervolgens past de politieke commissie een beproefde methode toe om directe verantwoordelijkheid te ontwijken: het dossier wordt formeel ingepland en 'geparkeerd' voor een toekomstig commissiedebat over de uitvoering van de sociale zekerheid. Daarbij wordt in de besluitvorming direct een procedurele beperking ingebouwd: men stelt expliciet dat de Kamer zich uitdrukkelijk niet bezighoudt met de individuele kwestie van de burger.

Hiermee degradeert het parlement de keiharde empirische data van een systematisch bevoegdheidsvacuüm tot een abstract beleidssignaal. De volksvertegenwoordiging erkent hiermee indirect dat de door henzelf ontworpen wetgeving in de praktijk vastloopt, maar weigert om op basis van een concrete casus direct de ministers ter verantwoording te roepen of in te grijpen in de lopende administratieve situatie.

# III. Overkoepelend, Bemiddeling & Maatschappelijke Resonantie

## ACADEMISCHE OBSERVATIELAAG

*De Retrospectieve Analyse van een Crisis*

Wetenschappelijke instituten, universitaire faculteiten voor sociaal recht en gespecialiseerde kenniscentra voor grenseffecten hebben binnen de rechtsstaat de taak om wetgeving te toetsen aan de maatschappelijke uitvoeringspraktijk. Zij analyseren structurele knelpunten in de sociale zekerheid en publiceren rapportages voor nationale parlementen en de Europese Commissie. Wanneer de gedocumenteerde Systeem-Audit in het voorjaar van 2026 bij diverse Nederlandse en Belgische universiteiten wordt ingediend als actuele casuïstiek van een transnationaal bevoegdheidsvacuüm, blijft een inhoudelijke reactie aanvankelijk volledig uit. De academische infrastructuur is primair ingericht op retrospectief onderzoek binnen afgebakende onderzoeksprogramma's en beschikt niet over een operationeel protocol om een lopende, individuele systeemblokkade in real-time te onderzoeken.

Deze radiostilte wordt in september 2026 doorbroken wanneer het geactualiseerde dossier het niveau van specifieke grensarbeid-expertise bereikt. Na een eerste bevestiging van dossierstudie door een hoogleraar aan een grensoverschrijdend onderzoeksinstituut, volgt een diepgaande inhoudelijke analyse door een onafhankelijk onderzoeker met een decennialange staat van dienst in grensoverschrijdende procedures. In deze uitwisseling wordt de casus niet langer als een geïsoleerd incident behandeld, maar getoetst aan de wisselwerking tussen de Europese coördinatieverordening *1*, de verordening inzake het vrij verkeer van werknemers *2* en de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie over fiscale en sociale gelijke behandeling over de grens *3*. Daarbij wordt tevens aan de hand van officiële correspondentie van de Europese Commissie gedocumenteerd dat formele inbreukklachten tegen België en Vlaanderen over de uitsluiting van grensarbeiders bij sociale voordelen en het Groeipakket al sinds 2022 en 2023 in een onderzoeksfase verkeren zonder definitief besluit.

De interactie met de onderzoekswereld verschuift van passieve observatie naar actieve verificatie wanneer de onderzoeker de exacte medische en fiscale parameters van het dossier via een anonieme steekproef voorlegt aan de Belgische belastingdienst voor niet-inwoners. De belastingadministratie bevestigt in deze steekproef schriftelijk dat bij het ontbreken van een Nederlands vervangingsinkomen boven de wettelijke drempel het spontaan toevoegen van medische verklaringen bij de aangifte een geldige route vormt om de fiscale handicapstatus naar Belgisch recht aan te tonen. Tegelijkertijd legt deze academische validatie de operationele grens van de wetenschap

bloot. Hoewel het onderzoek bevestigt dat nationale uitvoeringsorganen vastlopen op het ontbreken van digitale standaardsjablonen voor grensarbeiders met een medische beperking, bezit de academische laag geen uitvoerende of afdwingende bevoegdheid. De wetenschappelijke bevestiging van de weeffout opent geen gesloten databanken zoals de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en voorkomt evenmin dat een geslaagde fiscale correctie in het werkland via een gewijzigd inkomen nieuwe herberekeningen of terugvorderingen uitlokt bij inkomensafhankelijke regelingen aan beide zijden van de grens.

*1* Verordening (EG) nr. 883/2004 (inclusief Bijlage X inzake bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties).

*2* Artikel 7, lid 2 van Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie.

*3* Waaronder het Schumacker-arrest (C-279/93, 90%-norm), het arrest-Hendrix (C-385/17) en het arrest-Chefquet.

# BENELUX UNIE

*De Diplomatieke Observatie en de Afwezige Praktijk*

De Benelux Unie profileert zich van oudsher als de absolute pionier van de grensoverschrijdende samenwerking en als de proeftuin voor Europese integratie. Wanneer deze intergouvernementele organisatie echter wordt geconfronteerd met het aanhoudende administratieve vacuüm tussen de Belgische en Nederlandse sociale zekerheid, wordt het verschil tussen macro-diplomatie en micro-realiteit onmiddellijk zichtbaar.

De Benelux Unie functioneert in de kern uitsluitend als een overlegorgaan voor lidstaten. Zij produceren hoogwaardige verdragen, intentieverklaringen en academische studies over de arbeidsmarkt, maar zijn operationeel volledig onzichtbaar in de dagelijkse strijd van de grensarbeider. Er bestaat geen Benelux-noodloket dat een weigerend ziekenfonds ter verantwoording kan roepen of een vastgelopen fiscale datastroom kan deblokkeren.

Wanneer acute dossiers escaleren, verwijst de Benelux Unie standaard terug naar precies die nationale kanalen en organen (zoals SOLVIT of de ombudsmannen) die eerder in de keten al gefaald hebben. Het orgaan bewijst daarmee dat het weliswaar grensoverschrijdende visies kan opstellen, maar niet bereid of bevoegd is om bindende interventies uit te voeren ter bescherming van de burgers in het hart van hun eigen verdragsgebied.

# GRENSINFOPUNT (GIP)

*De Waarnemer Zonder Mandaat*

Het netwerk van GrensInfoPunten (GIP) is in het leven geroepen om de complexe wet- en regelgeving voor grensarbeiders te ontrafelen. Als advies- en informatienetwerk functioneren zij uitstekend: ze bieden een accuraat theoretisch overzicht van de rechten en plichten aan beide zijden van de grens. Echter, zodra de theorie vastloopt in een acute, praktische systeemcrisis, stuit ook deze organisatie op haar harde limieten.

Wanneer de grensarbeider in het voorjaar van 2026 de GIP's in de grensregio raadpleegt over de systematische weigering van de Belgische en Nederlandse instanties om elkaars medische en fiscale data te erkennen, kan het loket slechts bevestigen dat de burger theoretisch gelijk heeft. Zij bevestigen mondeling de knelpunten, maar weigeren de casus formeel als grensbelemmering aan te melden bij Schakelpunt.eu, met een beroep op hun strikte neutraliteit ten opzichte van overheidsinstanties. Het orgaan dat ontworpen is om de grens te overbruggen, kiest voor de veilige positie van de neutrale waarnemer.

Maar voor de burger die op dat moment medisch en financieel is vastgelopen, biedt deze signalering geen enkele operationele verlichting. Het GrensInfoPunt beschikt over nul uitvoerende macht. Zij kunnen geen enkel ministerie dwingen tot handelen, geen enkele uitkering lostrekken en geen enkele foutieve beslissing terugdraaien. Ze fungeren als uiterst vriendelijke routeplanners in een doolhof waarvan alle deuren elektronisch zijn vergrendeld door de natiestaat.

# MEDIA & PUBLIEKE INTELLECTUELEN

*De Vluchtige Resonantie van Schande*

Wanneer de juridische en politieke wegen afgesloten zijn, is de publieke opinie vaak het laatste redmiddel. De nationale pers, onderzoeksjournalisten en publieke columnisten hebben een natuurlijke interesse in verhalen over burgers die vermorzeld worden door falende algoritmes en weigerende instanties. De complexiteit en de brute onrechtvaardigheid van dit grensoverschrijdende dossier vormen een perfecte casus voor maatschappelijke verontwaardiging.

De impact van media-aandacht is echter buitengewoon vluchtig. Een vlijmscherp artikel of een kritische column genereert kortstondige reputatieschade voor de betrokken instanties, wat soms kan leiden tot een plotselinge, geforceerde "coulanceregeling" voor dit ene, specifieke dossier om de PR-crisis te smoren. Het lost echter de onderliggende architectuurfout niet op.

Belangrijker nog: algoritmes en geautomatiseerde beslisbomen in de kelders van ministeries lezen geen kranten. Zij trekken zich niets aan van opiniestukken. Zodra de nieuwscyclus twaalf uur later opschuift naar het volgende schandaal, verdwijnt de maatschappelijke druk. De frontoffice-medewerkers keren terug naar hun geprogrammeerde protocollen, de binaire uitsluitingen in de systemen blijven onaangeroerd, en de volgende grensarbeider valt exact in hetzelfde, nu geruisloze, gat.

# SOLVIT

*De Illusie van Europese Bemiddeling en de Tandeloze Tijger*

Wanneer twee natiestaten weigeren elkaars data te accepteren, is SOLVIT het officiële Europese vangnet. Dit netwerk, opgericht door de Europese Commissie, is specifiek bedoeld om grensoverschrijdende problemen van burgers met overheidsinstanties informeel en snel op te lossen, zonder tussenkomst van een rechter. In januari 2026 wordt er gelijktijdig een formeel verzoek ingediend bij zowel SOLVIT Nederland als SOLVIT België, ondersteund door de volledige empirische datamatrix van de systeemblokkades.

De afhandeling door dit Europese netwerk legt echter genadeloos de fundamentele zwakte van het systeem bloot. SOLVIT functioneert uitsluitend op basis van vrijwillige medewerking van de nationale overheden. Zodra de weigerende uitvoeringsinstanties (zoals de Christelijke Mutualiteit of het UWV) vasthouden aan hun eigen interne lezing van de regels, valt de bemiddelaar stil. SOLVIT heeft geen enkele dwingende bevoegdheid om een nationaal besluit te overrulen, zelfs niet als dit besluit in de praktijk de Europese samentellingsregels *1* onmogelijk maakt.

Het definitieve failliet van deze overkoepelende bescherming manifesteert zich in september 2026. Wanneer de burger, geconfronteerd met de aanhoudende impasse, aan SOLVIT verzoekt om het complexe dossier formeel door te verwijzen naar de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) voor harde bemiddeling, weigert SOLVIT dit. Het netwerk sluit het dossier af met het procedurele argument dat zij "geen formele schending van het Unierecht" kunnen vaststellen. Hiermee objectiveert SOLVIT de ultieme systeemparadox: een netwerk dat is opgericht om de muren tussen lidstaten af te breken, weigert te escaleren en valideert uiteindelijk de nationale blokkades die het verondersteld werd op te lossen.

*1* Verordening (EG) 883/2004, de basisverordening voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels binnen de Europese Unie.

## STRATEGISCHE BELANGENBEHARTIGING

*De Trage Molens van het Algemeen Belang*

Naast de overheid opereren er diverse niet-gouvernementele organisaties (NGO's), patiëntenverenigingen en macro-vakbondskoepels die zich richten op de bescherming van kwetsbare groepen en grensarbeiders. Bij de aanbieding van de Systeem-Audit erkennen deze strategische belangenbehartigers direct de waarde van het dossier. Zij zien een perfect, gedocumenteerd patroon van institutioneel falen dat naadloos aansluit bij hun eigen politieke strijdpunten.

De respons van deze laag toont echter de wrange realiteit van beleidsbeïnvloeding. Deze organisaties gebruiken de data graag als brandstof voor hun eigen lobbywerk. Het dossier wordt verwerkt in rapporten, als munitie gebruikt tijdens parlementaire hoorzittingen en dient als casestudy in strategisch overleg met ministeries. Dit proces, gericht op toekomstige wetswijzigingen, kent echter een tijdshorizon van vele jaren.

Voor de individuele burger, die hier en nu vastzit zonder inkomsten en verstrikt is in een administratief web, biedt deze belangenbehartiging geen enkele curatieve oplossing. Er is geen 'quick response team' dat actueel ingrijpt. De patiënt wordt hiermee gereduceerd tot een nuttig beleidsinstrument voor de lange termijn, maar wordt voor de kortetermijnoplossing volledig aan zijn lot overgelaten.

# IV. Europa

## EUROPESE COMMISSIE

*De Architect Zonder Operationele Slagkracht*

De Europese Commissie is de architect van het systeem. Zij schrijft de dwingende wetgeving die garandeert dat grensarbeiders niet tussen wal en schip mogen vallen *1*. Wanneer de gedupeerde burger de Commissie echter wijst op het feit dat zowel België als Nederland deze wetten in de praktijk openlijk negeren, toont de architect zich volstrekt machteloos op het microniveau.

Om deze bestuurlijke patstelling te doorbreken, wordt het dossier via een formele klacht geëscaleerd naar het Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie (DG EMPL). De klacht legt de structurele leemtes in de Europese verordeningen en de falende nationale uitvoering genadeloos bloot. DG EMPL bevestigt de theorie, maar ontbeert elke operationele bevoegdheid of afdwingbare machtsknop om een lokaal ziekenfonds of uitkeringsinstantie direct te corrigeren.

De Commissie mag niet ingrijpen in een individueel dossier. Het enige wapen dat zij bezit, is het opstarten van een zogenaamde inbreukprocedure tegen een falende lidstaat. Dit is echter een loodzwaar politiek en juridisch traject dat vele jaren in beslag neemt. Voor de burger die vandaag zonder inkomen zit omdat een grenscomputer hapert, biedt de Commissie daarmee enkel hoogdravende theorieën zonder enige praktische bescherming.

Wat op 25 september 2026 in het dossier komt, is dat de Commissie al sinds 2022 en 2023 meerdere inbreukklachten tegen België en Vlaanderen onderzoekt. Het gaat om klachten over de Vlaamse jobbonus, de studiefinanciering en het Groeipakket, alle drie onder Verordening 492/2011 over het vrij verkeer van werknemers. De Commissie heeft in al die jaren geen definitief besluit genomen — wat betekent dat de klachten nog open zijn. De klacht van dit gezin is geen geïsoleerd geval, maar sluit aan bij een reeks klachten die al jaren loopt.

*1* Verordening (EG) 883/2004, de hoeksteen van het vrije verkeer van werknemers die lidstaten verplicht elkaars sociale zekerheidstijdvakken naadloos over te nemen.

# EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (EHRM)

*Het Onbereikbare Gelijk*

Wanneer natiestaten door systematische uitsluiting de burger zijn inkomen en sociale rechten ontnemen, raakt dit aan fundamentele mensenrechten, zoals de bescherming van eigendom en een eerlijk proces *1*. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg is opgericht om hiertegen op te treden. In de praktijk is deze hoogste rechtszaal voor een medisch en financieel uitgeputte burger echter een fata morgana.

Het Hof hanteert namelijk een ijzeren toegankelijkheidsregel: een klacht wordt pas in behandeling genomen nadat álle nationale juridische wegen zijn uitgeput. De burger moet dus eerst jarenlang procederen tot aan de hoogste nationale rechtbanken in zowel België als Nederland. Dit vereist tienduizenden euro's aan advocatenkosten en jarenlange fysieke en mentale veerkracht. De paradox is absoluut: het falende overheidssysteem stopt alle inkomsten, waardoor de burger de financiële middelen verliest die nodig zijn om exact datzelfde systeem bij het Europese Hof aan te vechten.

Op 12 mei 2026 wordt het verzoekschrift per verzekerde post (Barcode LW024081984NL) naar de Griffier in Straatsburg verzonden. Op 18 juni 2026 verklaart het EHRM de klacht onontvankelijk en reduceert het transnationale probleem eenzijdig tot een geschil tegen de Belgische staat alleen.

*1* Verankerd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), in het bijzonder Artikel 1 van het Eerste Protocol (bescherming van eigendom, waaronder sociale uitkeringen vallen) en Artikel 6 (recht op een eerlijk proces).

# EUROPESE ARBEIDSAUTORITEIT (ELA)

*De Gesloten Nooduitgang*

De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) is specifiek in het leven geroepen om exacte situaties zoals deze op te lossen: het faciliteren van eerlijke arbeidsmobiliteit en het bemiddelen bij grensoverschrijdende geschillen over sociale zekerheid. Dit zou in theorie de krachtige bemiddelaar moeten zijn die over de nationale grenzen heen grijpt. De praktijk onthult echter een stuitende weeffout in het eigen ontwerp.

Wanneer de burger en de partner, geconfronteerd met weigerende natiestaten, de ELA formeel vragen om tussenbeide te komen, sluit de Autoriteit de deuren. De ELA hanteert namelijk de keiharde regel dat zij uitsluitend bemiddelt op verzoek van de nationale overheden zélf *1*. Individuele burgers mogen geen zaken aandragen. Dit creëert de meest problematische gesloten cirkel van het volledige dossier: de burger heeft de ELA nodig omdát de nationale overheden weigeren samen te werken, maar de ELA weigert op te treden totdát diezelfde weigerende overheden daar gezamenlijk om vragen.

Zelfs een formele poging in de nazomer van 2026 om SOLVIT in te zetten als doorgeefluik om dit obstakel te omzeilen, wordt geblokkeerd. Hiermee objectiveert de ELA haar eigen machteloosheid: het speciaal gebouwde Europese controleorgaan is volledig onbereikbaar gemaakt voor de mensen die het moet beschermen.

*1* Volgens haar mandaat kan de ELA enkel bemiddelen in geschillen tussen lidstaten, en kunnen verzoeken tot bemiddeling uitsluitend worden ingediend door nationale overheden (zoals ministeries of de RVA/UWV).

# EUROPESE OMBUDSMAN

*De Procedurele Blinde Vlek*

De Europese Ombudsman presenteert zich als de waakhond tegen 'wanbeheer' in de Europese Unie. Als het Belgische ziekenfonds en het Nederlandse UWV de Europese wetgeving aan hun laars lappen, lijkt dit de logische plek voor een klacht. Echter, zodra de Systeem-Audit hier belandt, loopt deze onmiddellijk stuk op een procedurele afbakening.

De Europese Ombudsman onderzoekt uitsluitend klachten over instellingen van de Europese Unie zélf (zoals fouten gemaakt door de Europese Commissie of het Parlement). Als een nationale instelling (zoals een lokaal ministerie) weigert een Europese verordening uit te voeren, verklaart de Europese Ombudsman zich per definitie onbevoegd. Men wordt simpelweg terugverwezen naar de Nationale Ombudsman, die — zoals eerder vastgesteld — de zaak eveneens weigert zolang er procedures lopen. De grensburger valt hierdoor precies in het procedurele gat tussen het nationale en het Europese toezicht: beide instanties kijken toe, maar geen van beiden acht zich bevoegd om op te treden.

Op 5 mei 2026 verklaart de Europese Ombudsman (eenheid Zaakbehandeling) klacht 1044/2026/MV niet-ontvankelijk. De Ombudsman stelt dat SOLVIT een nationale overheidsdienst is en geen EU-instelling, en dat de Europese Commissie, ondanks haar coördinerende rol, geen toezichthoudende bevoegdheid heeft in individuele gevallen.

# EUROPEES PARLEMENT

*De Democratische Echokamer en de Hoorzitting*

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de stem van de burger. Via de specifieke Commissie Verzoekschriften (PETI) hebben EU-burgers een direct kanaal om structureel onrecht en de schending van het Europese recht aan te kaarten. Om de politieke stilte te doorbreken, wordt het systeemfalen hier formeel ingediend, inclusief een expliciete eis voor het houden van een parlementaire hoorzitting. Het doel is om de administratieve blokkade letterlijk een gezicht te geven en de verantwoordelijke beleidsmakers in Brussel fysiek te confronteren met de data.

Hoewel deze commissie bevoegd en ontvankelijk is voor de systematische schending van grensarbeidersrechten, is het instrument in de praktijk veel te traag en machteloos om als effectief vangnet te dienen. Wanneer een dossier wordt geaccepteerd, kan het Parlement slechts een politieke echo produceren. Het kan vragen stellen aan de Europese Commissie, een resolutie aannemen of een brief sturen naar de falende lidstaat.

Het Parlement bezit echter geen enkele rechterlijke of uitvoerende macht om een minister, het UWV of een ziekenfonds te dwingen de uitkeringen te hervatten of de datablokkade op te heffen. De parlementaire route via PETI biedt erkenning op de lange termijn en agendeert het probleem, maar laat de burger in het heden financieel bloeden.

In september 2026 verschuift de status van het dossier. Op 25 september 2026 publiceert het Europees Parlement de officiële samenvatting van petitie 1034/2026 onder de beleidsterreinen Interne markt, Werkgelegenheid, Gezondheid, Sociale zaken en Grondrechten, met vermelding van België en Nederland als betrokken lidstaten. De petitie is vanaf dat moment openbaar op het petitieportaal en staat open voor medeondertekenaars. Het dossier is niet langer een privéklacht in een postbus, maar een formeel parlementair dossier dat door elke EU-burger kan worden ondertekend. Wat het Parlement echter niet kan, is een nationale uitvoeringsbeslissing terugdraaien — en dat blijft de fundamentele beperking.

# EUROPESE RAAD

*De Onzichtbare Top*

De Europese Raad, bestaande uit de regeringsleiders van alle lidstaten, bepaalt de algemene politieke richting van de Europese Unie. Binnen deze macro-architectuur bestaat de individuele grensarbeider simpelweg niet.

De Raad zet abstracte doelen op papier, zoals 'een naadloze interne markt' of 'digitale gegevensuitwisseling in 2030'. Ze zijn volstrekt losgekoppeld van de uitvoerende rampen die ontstaan wanneer hun politieke idealen botsen op de formele, nationale systemen van hun eigen thuislanden. Elke poging tot escalatie richting dit orgaan is bij voorbaat zinloos, omdat het instituut zo ver verwijderd is van de dagelijkse bestuurlijke modder, dat ze geen mechanismen hebben ingebouwd om individueel onrecht überhaupt te registreren, laat staan te repareren.

# V. Internationaal

## VERENIGDE NATIES

*Het Papieren Verdrag en de Absolute Afstand*

De escalatieladder eindigt op het allerhoogste mondiale niveau: de Verenigde Naties. Zowel België als Nederland hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (UN CRPD) *1* geratificeerd. Dit verdrag verplicht de lidstaten om de volledige maatschappelijke en economische inclusie van personen met een fysieke beperking te garanderen en administratieve barrières proactief weg te nemen. De theorie op mondiaal niveau is sluitend en belooft universele bescherming.

Wanneer de empirische data van de Systeem-Audit echter wordt afgezet tegen deze mondiale verdragen, wordt de ultieme institutionele ontkoppeling zichtbaar. Er is geen enkele operationele verbinding tussen het VN-verdrag in New York of Genève en de dwingende foutcode in het digitale loket van een lokaal ziekenfonds of uitkeringsinstantie. De natiestaat ratificeert de nobele doelstellingen op het macro-niveau, maar weigert deze rechten afdwingbaar te maken in de micro-systemen die de dagelijkse overleving van de burger bepalen.

De Verenigde Naties bezitten geen toezichthoudende machtsmiddelen om een falende nationale uitvoeringsinstantie te corrigeren. Zij fungeren louter als een moreel kompas op een afstand die zo groot is, dat de zwaartekracht van hun verdragen de grond nooit bereikt. Hiermee is de hiërarchie van het bevoegdheidsvacuüm compleet: van de tastbare, medische werkelijkheid van amputaties op de vierkante meter, tot aan de volstrekt machteloze theorie van mondiale mensenrechten.

Op 14 juli 2026 wordt het dossier officieel ingediend bij de Special Procedures van de Verenigde Naties ter aankaarting van de structurele schending van fundamentele rechten. De klacht wordt geregistreerd onder kenmerk hh33z8rq.

*1* UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, dat staten verplicht om de drempels voor personen met een handicap (inclusief in de sociale zekerheid) weg te nemen.